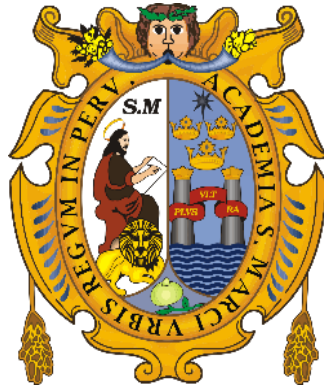


Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Escuela Académica Profesional de Ciencia Política



Título:

Análisis de la implementación del enfoque comunitario de salud mental (2018 - 2025): Estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre

AUTORES

Nayeli Castillo Montalvo - 21020444

DOCENTE

Christopher Gianmarco Cornelio Espinoza

CURSO

Taller de tesis IV

Lima – Perú

Ciclo “10”



ÍNDICE

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN	3
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	3
3. JUSTIFICACIÓN	9
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	10
5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.....	13
6. ESTADO DEL ARTE (BALANCE BIBLIOGRÁFICO).....	13
7. MARCO TEÓRICO.....	30
8. HIPÓTESIS.....	43
9. METODOLOGÍA	44
10. CRONOGRAMA DE TRABAJO.....	53
11. PRESUPUESTO	57
12. BIBLIOGRAFÍA.....	60
13. ANEXOS.....	66



1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema del presente trabajo de investigación es la implementación la política social de salud mental con enfoque comunitario, siendo el foco de análisis, el caso particular del Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) del Distrito de Pueblo libre en el periodo del 2025.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Año tras año, el Estado, en su rol de garante de bienestar social, se encuentra en una posición de afrenta a los problemas tradicionales de la sociedad civil, se suman a ellos, los fenómenos propios de la globalización como enfermedades virológicas o fenómenos sociales, que por su carácter global demandan una acción inmediata. Es por ello que cuando se suscitó la pandemia del COVID 19, esta produjo un remezón en el sistema de salud público peruano, el cual tiene desafíos en términos de abastecimiento y calidad de servicio en los últimos años previos a la pandemia. De ese modo, tras lo ocurrido, no solo la salud física fue objeto de preocupación, sino también la salud mental nacional; la cual volvió a ser foco de diálogo social y político. En ese sentido, se repuntó la necesidad de este servicio, en un contexto complejo donde se requería mayor capacidad de gestión pública.

Como se señaló, el tema de la salud mental se volvió nuevamente primordial en el contexto de la cuarentena, pero anterior a ese escenario, fue igualmente un tema de referencia dentro de la agenda política a partir de la época de inicio de los 2000, dado el auge del tema en el contexto internacional. Vinculante a esta idea, es que en el país se produjo la reformación del servicio de salud mental tradicional por el surgimiento de la salud mental comunitaria, primero puesto en las mesas de diálogo político, y luego se materializa el modelo a través de su implementación. Dicha materialización fue reto para el sistema de salud peruano, que por el lado institucional, el proceso tomó años de trabajo hasta la implementación del primer Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC).

Continuando con el contexto que propició los planes de acción, se puede señalar que un punto clave fue a partir de la relevancia que toma la salud mental dentro de la agenda política tras los eventos de estrés nacional a fines de los 90. Así mismo, es pertinente mencionar que para la actual fecha, los desórdenes mentales son considerados como un fenómeno global, de alta proliferación y con incidencia en la calidad de vida de



las personas. Tras esa denominación, la salud mental ya no solo queda relegada a la responsabilidad individual, sino que se convierte en un problema público. Es de así, que este aspecto de la vida ciudadana también se torna en una responsabilidad pública desde asegurar aspectos básicos como el acceso a servicios de salud mental públicos. Este deber también conlleva superar desafíos propios del sistema de salud tradicional, en aspectos como cobertura y calidad. Consecuentemente, tratar la salud mental de manera eficaz suponía un reto complejo de abordar, en ese sentido, para la Defensoría del Pueblo (2022), esto es tanto por el estigma persistente como por el factor de la gestión estatal. Es decir, de manera intrínseca, la percepción sobre la salud mental y lo que conlleva su tratamiento es estigmatizante; y por otro lado, es desafiante para la gestión pública insertarse en medidas que contribuyan a la salud mental de los civiles. Estos factores enmarcan bien la raíz de un abordamiento eficaz, por lo que es menester comprender como el vínculo de percepción/estigma y gestión pública es una combinación determinante para el devenir de la política de salud mental en el país.

Continuando con la premisa acerca de la importancia de la inserción de la salud mental en los servicios públicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retrata de forma precisa a la salud mental, se refiere a ella como “el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno”, de esta manera es que forma parte vital de nuestro bienestar general. Aquello insta a considerarla como componente necesario para el desarrollo de una vida saludable en todos los aspectos, por ello es que es integrada en los planes políticos como en el caso peruano, aunque ciertamente el proceso para tomarla en cuenta fue tardío, se valora que en los últimos años, el tema es revalorado tanto para los ciudadanos como parte vital de sus vidas, como para el Estado, en su labor de funcionarios, al proponer y promover el uso y proliferación de este servicio público.

Así mismo, el impulso de medidas que favorezcan la proliferación del servicio es justificada en cifras, debido a que la realidad nacional encierra un notorio problema social: el crecimiento exponencial de problemas mentales, así lo confirmó la directora ejecutiva de Salud Mental del Minsa, July Caballero Peralta, quién sostuvo que el incremento en casos es de un 20% desde precisamente el 2020. Por ello, para entender el grado de impacto negativo que las enfermedades mentales representan en la sociedad



civil; de acuerdo al informe de los lineamientos de política sectorial en salud mental “las enfermedades neuropsiquiátricas representan el 17,5% del total de carga de enfermedad, ocupando el primer lugar y produciendo la pérdida de 1 010 594 años de vida saludables (AVISAS), es decir, 33,5 años perdidos por cada mil habitantes” (MINSA, 2014); de modo que significa no solo la pérdida de la calidad de vida, sino que también repercute como factor de mortandad en el país, por lo que es viable considerarlo como un problema público.

Un desorden del estado emocional que mejor engloba este problema es la depresión, la cual es considerada una pandemia a nivel global por la OMS, y en el Perú es la causa de la pérdida de 224 535 años de vida saludables (3,9% del total), lo cual es determinado como 7,5 años perdidos por cada mil habitantes. Entonces, es preciso identificar que su relevancia se ve reflejada en el alto índice de casos de problemas de salud mental en el país, que la mueven a ser foco de interés político.

Y con la llegada de la pandemia en el 2020, este problema volvió a ser el foco de la conversación social y política por las repercusiones emocionales que el propio aislamiento social trajo consigo, mermando su carácter tabú, tanto en la sociedad como en la agenda política. Se reincide en recordar que el proceso histórico de reconstrucción de la política de salud mental se compuso de varios intentos por transmitir la necesidad de comprender la salud mental como un aspecto integral de la vida que debe ser garantizado por el Estado. Esto se refleja en que la implementación de una política de salud mental eficiente pasó por un largo recorrido, que comenzó con la necesidad de considerarse un problema público para posteriormente materializarse y llegar a cubrir a poblaciones vulnerables y grupos minoritarios, hasta contar con la actual política sectorial de salud mental que proyecta un enfoque comunitario en el abordaje.

En esa línea, los objetivos plasmados en la política sectorial y otros documentos de apoyo como los lineamientos y planes de estrategia, aún se encuentran en camino a concretizarse, dado que existen problemas que en conjunto limitan el desarrollo de un servicio de salud mental público eficiente y estandarizado para los ciudadanos en general. Esta serie de limitaciones surgen de aspectos intrínsecos de la sociedad como las brechas sociales existentes, las cuales dificultan el acceso a los servicios de salud mental, se conoce que “las brechas en el acceso a servicios de salud mental fluctúan entre 69% en Lima Metropolitana y el Callao y 93,2% en Lima rural. Además, la población que sí logra



acceder a estos servicios no tiene asegurado el tratamiento, recuperación y continuidad de cuidados a lo largo del curso de vida.”, esto de acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (INSM, 2003 -2012). Por lo tanto, en el ámbito de la ciudadanía, recibir un servicio de salud mental público implica superar limitaciones históricas como las brechas sociales.

En ese sentido, alineado al tema central de la presente investigación, se halla el problema propiamente enmarcado dentro del Estado para llevar a cabo la implementación del enfoque comunitario en los establecimientos de salud mental, es este factor, el objeto central de la investigación. El abordamiento de la salud mental como problema público para el Estado es un reto que puede ser superado dado que existen factores clave que han logrado acortar el camino hacia el ofrecimiento de servicios de salud mental y lograr lo más importante, que estos servicios sean aplicables a la realidad nacional. Tal como se mencionó anteriormente, la salud mental pública ha ido dejando de ser un problema relegado, para ser foco de discusión. Esto es evidenciado en el trabajo para la implementación de los CSCM en el 2015, para lo cual inicialmente se enfatizó en la importancia no solo de brindar un servicio de salud mental público, sino que estos sean garantizados bajo un enfoque comunitario, un modelo más integral que se enfoca en fortalecer los lazos sociales de la comunidad por medio de promoción, prevención y tratamiento ambulatorio.

Dicha reformatión de enfoque para la implemetación de los CSMC, es producto de una serie de factores clave como en primera instancia, una voluntad política fuerte que se exprese en políticas y programas, que conduzca una apropiada implementación de la política social de salud mental hasta lograr el valor público de las políticas materializadas, en este caso, de los CSMC. Sin embargo, es clave enfatizar que la existencia de CSMC no se traduce de manera automática en mejores servicios de salud mental, puesto que cada CSMC está distribuido en distintos distritos y provincias de Lima y Perú. Y este aspecto es clave a considerar, puesto que la gestión pública que se suscite dentro de estos distritos es particular y distinta, pero así mismo es vinculante con la gestión del CSMC de su localidad. Es decir, los resultados y actividades que pueda emprender un CSMC no son solo competencia de los profesionales a cargo del centro, o de la dirección del Ministerio de Salud, también es un trabajo que requiere ir de la mano de los funcionarios del distrito/provincia en cuestión.



Se reincide que las limitaciones tradicionales para el avance sostenido de este proyecto son de carácter múltiple, por ejemplo, se puede señalar que una de las limitaciones es el presupuesto designado para el sector de salud mental, el cual de acuerdo a la plataforma “Consulta Amigable” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), equivale al 1,6% del presupuesto para el sector salud, de modo que resulta una dificultad para el desarrollo de la política sectorial, pero este aspecto puede ser superado con expresión de voluntad política, tal como César Vásquez, Ministro del Minsa, ha expresado tras su paso en el Instituto de Salud Mental Noguchi, al señalar que apuntan a “tener una red nacional de salud mental consolidada, que tenga absolutamente monitorizados a los más de 300 establecimientos de salud mental comunitarios que tendremos al término este año”, lo que expresa su intención de consolidar la proliferación de CSMC.

Es entonces, que ámbitos de la salud específicos como la salud mental que solían desarrollarse menor grado, han ido tomando mayor fuerza debido al aumento de diagnósticos, por lo que para el presente año, los CSMC son los focos referentes de concentración para el tratamiento de desórdenes mentales y adicciones, es decir, son la materialización de la estrategia en salud mental desde un enfoque que pasó del modelo biomédico y hospitalario al comunitario, a fin de garantizar un mejor tratamiento.

Sin embargo, es aún un reto entender que factores hace posible garantizar la eficacia de estos centros y sus servicios, dado que la expansión implica mayor cobertura mas no resultados en cuanto al valor público. Es por ello, que la presente investigación se centra en analizar fenómenos políticos relacionados a la gestión que impactan directamente en los resultados de proyectos innovadores como los CSMC, puesto que se puede señalar que ante la cantidad exponencial de centros a nivel nacional, se espera que estos impacten positivamente, tal como un proyecto público aspira a ser.

Continuando, se colige que la problemática de la investigación radica en la existencia de limitaciones para brindar servicios que pueden ser superadas si se recurre al reforzamiento de factores estudiados en la Ciencia Política, tal como la volunta política, la implementación de políticas públicas y el valor público. Estas limitaciones se traducen en irregularidades como establecimientos no fijos, o pocas actividades de dispersión, promoción y prevención a diversos sectores de la comunidad, etc, que pueden suscitarse ante las variedad de centros inmersos en distintos contextos a nivel de gestión local. En



ese sentido, la presente investigación se enfoca en la importancia e impacto que tiene la implementación de políticas con enfoque comunitario a nivel local o distrital para el desarrollo de este tipo de centros, que requieren de un esfuerzo mayor para realizar sus actividades de integración comunitaria, por lo que el trabajo eficiente de estos implica elementos necesarios como la articulación, concertación y participación, aspectos que solo pueden propiciarse si la implementación es eficiente.

Por ello, se toma como caso específico del desenvolvimiento del centro comunitario “Honorio Delgado” de Pueblo Libre, el cual brinda servicios para niños, adolescentes y adultos del distrito en cuestión y de distritos periféricos (Breña y Jesús María), la atención ofrecida responde al mismo enfoque comunitario planteado por la política sectorial en salud mental, que propone brindar diversos servicios, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. El centro contiene una gama de servicios que son brindados de forma escalonada, desde la acogida hasta el tratamiento de terapia y/o farmacológico, así mismo, es pertinente mencionar que hay una demanda considerable en este centro, proveniente de vecinos del distrito y de los alrededores.

Este caso es el preste a analizar debido a que el centro posee características resaltantes que lo colocan como modelo entre los demás centros, dado ha una presencia fuerte en redes sociales vinculada a la promoción de la salud mental y la dispersión de numerosas actividades ambulatorias, por ello, es indispensable considerar los factores que posibilitan la entrega de servicios decentes a la comunidad a fin de que sean replicados no solo en demás centros, sino también en diversos sectores.

Por último, la presente investigación se propone analizar la implementación del enfoque comunitario en salud mental desde el estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Este centro ha mostrado particular visibilidad pública y despliegue de actividades de promoción comunitaria, lo que lo convierte en un caso pertinente para indagar cómo inciden los factores político-institucionales en su funcionamiento y en la percepción del servicio. En concreto, se busca evaluar la influencia de la voluntad política institucional-sectorial, examinar las estrategias implementadas por el equipo profesional y comprender el impacto del modelo en la satisfacción de los usuarios. De esta forma, el estudio aportará evidencia sobre las condiciones que facilitan o limitan la materialización del enfoque



comunitario, así como sobre los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar un servicio de salud mental con verdadero valor público.

3. JUSTIFICACIÓN

El presente estudio se justifica en primer lugar por su **relevancia en el ámbito social**, en tanto aborda una problemática de salud pública que ha cobrado creciente importancia en el país: el acceso a servicios de salud mental con enfoque comunitario. A pesar de los avances normativos e institucionales impulsados desde la promulgación de la Ley N.º 30947 y la implementación progresiva de Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), persisten importantes brechas en la implementación efectiva del enfoque comunitario en los niveles locales de atención. Por ende, analizar cómo se lleva a cabo este proceso en un caso específico, como el del CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre, permite comprender de manera situada y particular, aspectos como las oportunidades, limitaciones y condiciones que favorecen o dificultan una atención integral, accesible y centrada en la comunidad. Asimismo, la salud mental sigue siendo un campo social caracterizado por estigmas y escasa visibilidad institucional, a pesar de su alta incidencia en el desarrollo del bienestar social, por lo que investigaciones como esta contribuyen a visibilizar su importancia y a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los servicios a los que pueden acceder de manera pública.

Desde el ámbito académico, la investigación resulta pertinente porque contribuye al análisis de políticas públicas desde un enfoque cualitativo, territorial y orientado a la generación de valor público. A través del estudio de caso, se propone analizar cómo la voluntad política institucional-sectorial, la gestión local y la participación ciudadana se articulan en el proceso de implementación de una política social compleja. Este enfoque permite no solo documentar la ejecución de lineamientos técnicos, sino también interpretar las relaciones y resultados percibidos por los actores involucrados. La articulación entre teoría de la implementación de políticas sociales con enfoque comunitario y nociones de valor público constituye un aporte conceptual que puede ser aplicado en otros estudios similares, especialmente en contextos urbanos y de atención primaria en salud.



Además, la investigación aborda un vacío en el estado del arte, dado que la mayoría de estudios sobre salud mental en el Perú se han centrado en los aspectos clínicos, mientras que el análisis de los factores político-institucionales de la implementación ha sido menos desarrollado. En particular, existe escasa evidencia sobre cómo se manifiesta la voluntad política a nivel sectorial y territorial, y sobre cómo la implementación del modelo comunitario impacta en la percepción y satisfacción de los usuarios. Al recoger tanto la perspectiva institucional como la experiencia ciudadana, el estudio ofrece una mirada integral y situada, que puede ser de utilidad para el diseño de mejoras en la política pública y para la toma de mejores decisiones desde los distintos niveles de gobierno y el propio Ministerio de Salud.

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Pregunta central:

- ¿En qué medida los factores político-institucionales asociados al enfoque comunitario de salud mental inciden en la implementación del enfoque comunitario y en la satisfacción de los usuarios en el Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre durante el periodo 2018–2025?

La presente interrogante busca indagar de manera articulada cómo determinados factores institucionales y políticos, como el respaldo normativo, el financiamiento, el compromiso sectorial, y la articulación institucional, condicionan tanto la implementación del enfoque comunitario de salud mental como la experiencia de los usuarios frente a los servicios brindados por el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre, entre los años 2018 y 2025. Esta formulación permite comprender, desde una perspectiva integrada, el papel del entorno institucional en la consolidación del modelo comunitario y cómo dicha estructura se refleja en la calidad percibida del servicio, considerando variables como la participación, la sostenibilidad de las acciones y la generación de valor público.

Dicha pregunta se sustenta en antecedentes teóricos y empíricos que analizan el enfoque comunitario de salud mental como una política social innovadora que requiere condiciones institucionales específicas para su adecuada implementación. De ese modo, estudios previos han abordado la relevancia de la



voluntad política, la gobernanza multinivel y la asignación de recursos para garantizar la continuidad de modelos de atención basados en derechos, cercanía territorial y participación comunitaria (Vasquez et al., 2021; Chiappe y Leguía, 2022; CIDH, 2021). Sin embargo, gran parte de estas investigaciones han centrado su atención en los lineamientos generales del enfoque o en experiencias macro nacionales, sin profundizar en estudios de caso que analicen de forma detallada la interacción entre actores institucionales y ciudadanos en contextos locales.

En ese sentido, esta investigación aporta al campo de estudio al vincular dos dimensiones fundamentales: el análisis de condiciones institucionales sectoriales (como expresión de voluntad política) y la percepción de valor público desde la experiencia de los usuarios. De esta manera, se propone una mirada integrada que permite visibilizar tanto los avances como las brechas existentes en la implementación del modelo comunitario, con la finalidad de generar evidencia útil para su fortalecimiento y replicabilidad en otros contextos del país.

Preguntas específicas:

- ¿De qué manera la voluntad política institucional-sectorial influye en el proceso de implementación del enfoque comunitario en el CSMC de Pueblo Libre en el periodo 2018-2025?

Esta pregunta busca analizar cómo las decisiones, prioridades y acciones promovidas por los niveles institucionales del sector salud —en particular el Ministerio de Salud y la DIRIS Lima Centro— han influido en la implementación práctica del modelo comunitario en el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”. Ello implica identificar mecanismos de respaldo normativo, presupuestal y operativo, así como evaluar su sostenibilidad y articulación con otros niveles de gobierno. Esta interrogante se fundamenta en diversos estudios que han abordado el rol determinante de la voluntad política institucional en la efectividad de políticas sociales. Por ejemplo, se ha señalado que la implementación del enfoque comunitario de salud mental requiere no solo de un marco normativo favorable, sino de una voluntad política sostenida, que se traduzca en financiamiento, infraestructura, acompañamiento técnico y



reconocimiento estratégico de la salud mental como prioridad pública (Cáceres, 2021). Asimismo, investigaciones recientes también evidencian que, en ausencia de dicha voluntad, las experiencias locales pueden fragmentarse o debilitarse en su impacto (Chiappe y Leguía, 2022), lo que vuelve necesario analizar este factor en profundidad a nivel sectorial y territorial.

- ¿De qué manera se implementa el enfoque comunitario de la política social de salud mental por parte del equipo del CSMC “Honorio Delgado”?

Esta pregunta específica se centra en indagar cómo el equipo profesional del Centro implementa en la práctica los principios del enfoque comunitario: territorialidad, intersectorialidad, participación social, y promoción de derechos. Ello implica examinar las estrategias empleadas, los espacios comunitarios desarrollados, las acciones coordinadas con otros actores y las barreras institucionales que condicionan la ejecución del modelo. Esta línea de análisis se respalda en estudios que destacan que, si bien el modelo comunitario está claramente definido en la política nacional, su aplicación práctica varía según las capacidades del equipo técnico, el contexto local y el nivel de acompañamiento institucional (Mendoza, 2020; Chiappe & Leguía, 2022; Vasquez et al., 2021). Asimismo, se reconoce que los CSMC cumplen un rol central en traducir los lineamientos nacionales en acciones concretas, pero enfrentan desafíos como baja articulación con actores comunitarios. Por ello, comprender cómo se aplica el enfoque en un centro específico permite generar aprendizajes para fortalecer la implementación nacional.

- ¿Cuáles han sido los efectos de la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre a nivel de percepción y satisfacción en la cadena de valor público del servicio ofrecido?

Esta pregunta se orienta a explorar los resultados e impactos percibidos por los usuarios del CSMC en relación con la implementación del enfoque comunitario. Se busca identificar en qué medida los servicios brindados generan confianza, legitimidad, bienestar y sentido de pertenencia, elementos clave en la construcción de valor público desde la perspectiva ciudadana. Desde el estado del arte, se reconoce que el enfoque comunitario tiene como objetivo no solo ampliar la cobertura en salud mental, sino transformar la relación entre el Estado y los



ciudadanos en términos de corresponsabilidad, dignidad y apropiación de derechos (Chiappe y Leguía, 2022). Sin embargo, los estudios empíricos centrados en la experiencia de los usuarios son aún escasos, y más aún aquellos que vinculan dicha experiencia con el concepto de valor público. Por tanto, esta pregunta busca aportar una mirada desde abajo, mediante las voces de quienes reciben la atención, para comprender cómo se valora y percibe el servicio en términos de legitimidad, pertinencia y efectividad.

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo general:

- Analizar el impacto de la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre en la satisfacción de los servicios brindados por el CSMC de Pueblo Libre en el periodo 2018–2025.

Objetivos específicos:

- Comprender cómo la voluntad política institucional-sectorial del MINSA y la DIRIS se expresa en acciones concretas de respaldo técnico, normativo y operativo que influyen en la implementación del enfoque comunitario en el CSMC de Pueblo Libre durante el periodo 2018-2025.
- Analizar la implementación del enfoque comunitario de la política social de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado', identificando las estrategias, mecanismos de participación y factores que dificultan su aplicación desde la perspectiva del equipo profesional.
- Determinar los efectos de la implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre en relación a la creación de satisfacción y percepción en la cadena de valor público del servicio del centro.

6. ESTADO DEL ARTE (BALANCE BIBLIOGRÁFICO)

La bibliografía revisada sobre la gestión estatal de la salud mental mediante los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) es limitada en el aspecto de la teoría sobre el enfoque y los resultados, sin embargo, resulta provechosa para la presente investigación. A nivel nacional, las investigaciones orientadas a la gestión de políticas públicas sociales para abordar la salud mental desde un enfoque distinto al hospitalario



han surgido a partir del siglo XXI, a consecuencia de los daños psicológicos ocasionados por la intensa época de los 80 y 90's, lo que demostró una necesidad por motivar un cambio de foco hacia la salud mental desde la perspectiva estatal. A partir del problema planteado, se amerita el replanteamiento de los temas que sostienen la salud mental en el país, por ello, se tomó en consideración revisar textos que aborden los tres ejes. La estructura de este balance bibliográfico se organiza de la siguiente manera: el primer eje analiza investigaciones sobre la concepción de la salud mental en la políticas públicas y su consecuente implementación; el segundo explora las implicancias del enfoque comunitario de la salud mental en el ámbito de la política y el tercero examina las limitaciones y oportunidades que se presentan en el proceso de implementación de los Centros de Salud Mental Comunitarios.

. Eje temático 1: La salud mental desde el ámbito de las políticas públicas.

La salud mental es un ámbito de la vida del ser humano crucial para su desarrollo óptimo y que ha sido tratado “discretamente” por el Estado, aunque es un aspecto importante para la evolución de la sociedad en conjunto y el desarrollo integral de las personas en su individualidad, ha resultado ser un ámbito dejado de lado para dar preferencia a otros sectores de la gestión estatal, lo que a contribuido con el estigma y desinterés por la salud mental como parte fundamental de la vida personal y social.

De acuerdo con Echavarría (2012), la salud mental es influenciada por factores tanto sociales como biológicos. Esto conduce a inferir que no es una condición estática, sino sujeta a variaciones y fluctuaciones de cierta intensidad; implica la capacidad de un individuo para establecer relaciones armoniosas con otros y para participar en modificaciones de su ambiente físico y social o de contribuir con ello de modo constructivo, esta interpretación de lo que es salud mental a nivel de surge a partir de la noción brindada por la OMS en un contexto socio-político álgido entorno al fin de la Segunda Guerra Mundial, en dicho contexto, el organismo internacional buscaba definir la salud mental de un modo que refleje su valor para el desarrollo de las sociedades; y en el caso de la época, para que sea el medio de tratamiento directo a los millones de afectados de las guerras. El interés propiciado por la OMS hacia la salud mental fue imitado por diferentes países y autores de manera creciente, lo que condujo a una serie de



consideraciones políticas de este ámbito de la salud en la realidad social de la época posterior a la guerra.

Para reafirmar la cabida de la salud mental en los Estados postguerra a partir de su acogida en las asambleas de la ONU, el estudio de Lopera (2014), expone la relación entre el concepto de carácter integral de salud mental que adquiere el organismo internacional y la implementación de políticas públicas del mismo carácter integral que se fomentaron desde el reconocimiento internacional impulsado por la ONU, lo que posteriormente da cabida a que se consagre a la salud mental como un derecho fundamental, este importante hito se encuentra explícito en la Carta de las Naciones Unidas (ONU, 1946) marca inicio de la consagración internacional de la salud mental puesto que podía ser ámbito de diálogo político y así, lograr ser implementada como servicio mediante políticas públicas.

Entonces, se sostiene que el establecimiento de un concepto integral que girara en torno a su carácter de principio básico para lograr el conjunto de relaciones armoniosas y la seguridad de las naciones en su constitución, contribuyó a que posteriormente se expresen principios que permitieran la consecución de este fin. De ese modo, el acuerdo y diálogo impulsado por organismos internacionales acerca de la salud mental como derecho fundamental, abarca en gran medida que la implementación de este ámbito en las agendas políticas de los estados que jugaron un rol principal en el contexto de la Guerra Fría, motive a otros Estados como en el continente Latinoamericano a considerar la incorporación de salud mental dentro de sus planes, y en mayor medida a objetivizarla positivamente en el escenario internacional.

En esa misma línea, ante el incipiente interés por garantizar la salud mental a escala nacional, se busca contar con herramientas que encaminen a una buena implementación de políticas públicas. De ese modo, los autores Torres, Castellanos, Vásquez y Chang (2021) en “Revisión epidemiológica de los trastornos mentales en el Perú”, convergen que incorporar estudios epidemiológicos sobre trastornos mentales en las políticas de salud mental vigentes es una de las mejores herramientas para implementar políticas que sean sostenibles a largo plazo y con mayor capacidad de implementación, debido a que este tipo de estudios posibilitan un pronóstico idóneo para las políticas de planificación, al considerar características particulares de cada región donde se desee implementar, de modo que se logren legislar políticas que cubran brechas



sociales. Además, este tipo de estudios pueden ser una buena propuesta de innovación para la investigación de la salud mental con objetivo de implementar políticas que cubran las necesidades de la población tan heterogénea del país.

Así mismo, para reforzar la idea de la implementación de políticas de salud mental como deber del Estado en el marco de la constitución política, Paola Ticona Calo (2019), introduce en su investigación titulada “El derecho a la salud mental en el Perú del siglo XXI ¿un derecho protegido o un derecho postergado por el estado peruano?” que el Estado, a lo largo de la historia de la Constitución, ha dejado en evidencia la falta de coherencia que existe entre los compromisos asumidos por y las medidas efectivamente adoptadas por él en materia de salud mental. De esta manera, se sostiene que no existe una relación consistente entre el derecho a la salud mental, las opciones políticas, las decisiones tomadas y la demanda de salud mental, lo que problematiza la obtención de una óptima salud integral como derecho básico. Por ello, se defiende que la salud mental ha sido un derecho postergado por la agenda política de modo que ha afectado la implementación de políticas públicas en el marco de la constitución.

Por otro lado, es clave comprender el recorrido histórico - político de la implementación de políticas públicas en salud mental nacional tras la asunción de este como deber estatal. Cabe rememorar que la salud mental, tuvo un rol marginal dentro de la política de salud peruana entre los 80 y 90, evidenciado en su estricta importancia como cuestión de bienestar económico y social, situaciones de las que gran parte de la población peruana careció durante esas décadas (Palma, 2019). En los próximos años, con el retorno de la democracia, y especialmente el Informe presentado el 2003 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), se visibilizó la precariedad del estado de la salud mental en el país, pero esto fue tomado solo como punto de discusión, ya que tal como lo señala la investigación de Palma (2019), los siguientes años se siguió limitando la prioridad del sector salud en aspectos de gasto público. Solo entre 2004 y 2006, se publicaron diversos planes y estrategias, que se materializaron en un nuevo “Plan Nacional de Salud Mental” (2006), el recorrido para los resultados fue lento, pues es hasta el 2015 que se inicia el ambicioso plan de implementar CSMC a nivel progresivamente nacional.

De esa manera, es clave seguir el recorrido de la salud mental en la política nacional, por lo que para abordar los factores que explican los cambios en la formulación



de la política pública de salud mental en el Perú durante el periodo específico del 2003 al 2016, se recurrió a la investigación titulada “Las coaliciones promotoras de la política pública de salud mental en el Perú” de Mónica Hayakawa (2019). En este texto la autora aborda que la política de salud mental en país desde el 2003 se reconoce por su mínima movilización social, ya que los propios afectados no se encuentran aptos para movilizarse y exigir el derecho a la atención de calidad debido a su reciente estado de vulnerabilidad social tras los eventos políticos a fines de los años 90. Sin embargo, alega que esto le da importancia a grupos especializados como a las “comunidades de políticas”, que en un contexto de formulación de políticas públicas, se refiere a un grupo de actores que interactúan en un proceso político específico y son reconocidos por factores como su tamaño, la frecuencia de las interacciones y las creencias compartidas; así mismo, estas comunidades pueden ser formales o informales, y su objetivo principal es influir en las políticas públicas. Dicho esto, la importancia de estos grupos fue alta debido a que en un contexto político crítico como el de aquella época, se colocaron como centros de discusión y reclamo en nombre de los usuarios afectados por la crisis social para la legislación de políticas de salud mental.

Además, Hayakawa (2019) sostiene que la política de salud mental entre 2003 y 2016 ha sufrido una alta volatilidad en el tiempo a pesar de la poca discusión en torno al debate entre actores estatales y no estatales, lo que la lleva a plantear sobre cuáles son los factores que producen esos cambios drásticos en la política de salud mental. Para ello se asienta sobre la base de la existencia e influencia de coaliciones promotoras de la salud mental, las cuales son grupos heterogéneos de actores (profesionales, funcionarios, ONGs, etc) que comparten creencias y valores sobre la importancia de la salud mental, y cuyo papel recae en que al tener intereses y enfoques particulares, tienen resultados propios que responden a sus creencias, por ejemplo, la coalición biomédica es la más clásica y tuvo predominancia a inicios de los 2000, con un enfoque netamente biomédico, trató de llevar la salud mental pública por el camino del tratamiento médico - farmacológico de los pacientes, el enfoque de esta coalición estuvo presente en los gobiernos a inicios de los 2000, donde aún se brindaba servicios de salud de manera tradicional, incluyendo la salud mental.

Otra coalición que fue tomando presencia fue la de enfoque socioeconómico, misma que fue característica de los gobiernos a partir del 2010, este tipo de coalición



conduce a tratar la salud mental sobre la base del acceso respetuoso de los servicios, sensibilidad con las personas, e implementación de centros comunitarios de salud mental, estas medidas resultan de su creencia particular del bienestar como salud mental. Es así, que la autora considera que el cambio de contexto político y la alineación a acuerdos internacionales repercuten como factores externos en la presencia de cierto tipo de coaliciones promotoras. De este modo las coaliciones son, en gran medida, la causalidad de los cambios en la política pública de salud mental, dado a que su contenido se alinea al tipo de coalición que se halle en el gobierno de turno; sin embargo, esto no representa una imposibilidad de convergencia, es decir: pueden ser incluyentes entre sí para dar continuidad al desarrollo de la salud mental mediante políticas cohesivas.

Es así que, en relación al recorrido político de las políticas de salud mental en el país, se presenta de manera consecuente, la implementación de políticas en base a la reformación de este servicio tradicionalmente biomédico. Por ello, en la investigación de Castillo y Cutipé (2019) titulada “Implementación, resultados iniciales y sostenibilidad de la reforma de servicios de salud mental en el Perú, 2013-2018”, los autores recogen la información más reciente sobre los servicios de salud mental gestionados por la política sectorial en el periodo de 2013-2018, momento en el se produce la transición de políticas públicas basadas en el enfoque biomédico al enfoque comunitario de salud mental. Ambos autores consideran que, a partir de ese periodo, se suscita un mayor despliegue de esfuerzos por reforzar la política de salud mental en el país, y que, dentro de este periodo, se produjo el importante cambio al enfoque comunitario. En efecto, lo más destacable es que esta reconstrucción de la salud mental fue motivada y materializada por la cooperación entre organismos estatales y no estatales, lo que posibilitó una mayor cobertura del servicio de salud mental. En ese sentido, es pertinente señalar que, tras la promulgación de la Ley 29889 en el 2012, se haya desarrollado una reforma de los servicios de salud mental y que el resultado se traduzca en la implementación de CSMC.

En resumen, las investigaciones revisadas ofrecen una visión detallada sobre la inclusión de la salud mental en la agenda política nacional y de manera consecuente, en las políticas públicas del país, los cuales resaltan tanto el recorrido internacional como el contexto histórico nacional para la materialización de la salud mental en la agenda política. En estas investigaciones, Echavarría (2012) comparte aportes a la comprensión del concepto integral de la salud mental en las políticas públicas en el marco



internacional, y se suma Lopera (2014) para relacionar el valor que le aporta el reconocimiento internacional al tema de la salud mental en los Estados. De modo que una vez puesto en la agenda, Torres, Castellanos, Vásquez y Chang (2021) sostienen la importancia de usar herramientas que colaboren a implementar políticas eficaces como lo son estudios de carácter epidemiológico para prevenir y planificar apropiadamente, ya que Calo (2019) enfatiza que esta labor es un deber del Estado que amerita dejar de ser relegado, tal como Palma (2019) lo evidencia en su exploración de la marginalización de la salud mental durante la primera década de los 2000. Es así que los esfuerzos por cambiar de enfoque, son para Hayakawa (2019) un aspecto delicado que resulta de las coaliciones propias de cada gobierno de turno, y que afectan directamente en la dirección de la política de salud mental. De ese modo, Castillo y Cutipé (2019) recogen información valiosa acerca de los cambios e inercias en el proceso de implementación de nuevas estrategias en la política de salud mental nacional, y destacan la necesidad del rol participativo del Estado para asegurar una dirección clara de la política. En conjunto, estos estudios coinciden que el punto de partida para la consideración de la salud mental dentro de la agenda política fue sobre la base de un continuo postergamiento, y a pesar de que se producían debates en torno al tema, este fue un ámbito que no consiguió ocupar mayor interés dentro de la agenda a comparación de otros asuntos públicos, por lo que destacan en la importancia de discutir y considerar la salud en los planes políticos, a fin de concretizar políticas públicas consistentes.

. Eje temático 2: Enfoque comunitario de las políticas de salud mental.

El enfoque de las políticas públicas de salud mental en el país no ha sido inmutable desde la incorporación de las mismas. Tras los eventos ocurridos en el gobierno de Alberto Fujimori, el Estado reconoció a la salud mental como parte del proceso de recuperación de la población por lo que se brindó este servicio a la comunidad con un enfoque biomédico, que surge de su vínculo con el concepto de la salud integral, y se le asocia a la salud física. Posteriormente los índices de problemas de salud mental ascendieron conforme los gobiernos iban en transición, y los cambios del contexto político permitieron el cambio de enfoque para el abordaje de los servicios de salud mental en el país, de ese modo, el incipiente aumento de problemas de salud mental propició la legislación de la ley 29889 del año 2012. Esta ley refuerza las estrategias de



intervención en salud mental, al establecer al enfoque comunitario como enfoque alternativo de atención, y si bien no fue explícita en las prácticas a seguir en este enfoque alternativo, fue un hecho que condujo la implementación de centros que operen bajo este enfoque.

En este eje temático, se revisaron estudios que giran en torno al contenido del enfoque comunitario y su valor dentro de los servicios de salud mental. De ese modo, cabe precisar que la interpretación de lo que es el enfoque comunitario en servicios de salud mental puede ser amplia, por ello, Dávila (2020) delimita el concepto de enfoque comunitario de manera sustancial al comprender que la salud mental es inherente al ser humano y su ambiente, y precisamente ello es la base para comprender el enfoque comunitario y ofrecer un tratamiento efectivo. La autora reconoce que no hay salud mental si se desliga al ser humano de su ambiente comunitario, donde aprende y construye su identidad personal así como relaciones que mantienen su bienestar integral.

Así mismo, Montero (2004) explica que el enfoque comunitario es una método para impulsar la salud mental integral en un espacio recíproco como lo es la sociedad, donde se producen transformaciones significativas en la relación persona-comunidad a partir de la participación y el compromiso. Bajo ese entendimiento, la autora trae a colación que uno de los aportes más valiosos de este enfoque a la salud mental es la implementación de centros que operen bajo la teoría del enfoque comunitario por medio del conjunto de servicios interdisciplinarios. De ese modo, Montero (2004) argumenta que la implementación de este enfoque es en efecto más integral que un enfoque biomédico, puesto que la atención no es limitante a proporcionar medicación, sino que refuerza la recuperación desde el desarrollo individual y social.

Lo expuesto por los autores indica que el enfoque comunitario es un modelo viable a transicionar, pero esto puede ser difícil en contextos nacionales donde ya existe un enfoque tradicional predominante. Por ello, los autores Peña, González y Parada (2021) estudian la realidad de la salud mental en el contexto latinoamericano, donde a través de su análisis de la implementación de políticas públicas desde la óptica del enfoque biomédico y comunitario, logran identificar que las condiciones socioeconómicas de un país condicionan su desarrollo en salud mental, y que por ende transicionar a un enfoque comunitario puede tomar años de trabajo. En consecuencia, sostienen que el modelo comunitario no es el único modelo a seguir si es que se desea conseguir avances en salud



mental a nivel nacional; más bien consideran óptimo que se de la complementación de enfoques para lograr una transición eficaz.

Peña, González y Parada (2021) también consideran que resulta complicado adoptar un enfoque comunitario en países como los de Latinoamérica, donde al menos el tercio de ellos, aún no definen una política nacional de salud mental. Sumado a ello, consideran que la misma gestión política, es un reto a superar para la implementación de un enfoque en la política de salud mental, puesto que esta se caracteriza por disparidades de financiamiento y cobertura entre los diversos servicios públicos a ofrecer. En el caso de Latinoamérica, un ejemplo de esto, es que los países con menos ingresos, presentan dificultades para financiar y operacionalizar un programa de salud mental, y resulta incluso más complejo, adoptar un enfoque determinado, debido a que se requiere previo análisis y conocimiento de las características socioculturales y posibilidades económicas del país.

Por ello, ciertamente el camino para ir de un enfoque a otro más integral requiere sobrepasar las limitaciones sociales, que con el tiempo valdrán la pena debido a que el enfoque comunitario persé, desde cualquier espacio de servicio público, contribuye a superar limitaciones sociales como la desigualdad e inequidad. Así lo reafirma Ramos (2000) al considerar que el enfoque comunitario se destaca por trabajar en la disminución progresiva de disparidades y en busca de mejorar la distribución de oportunidades para las personas que conforman una comunidad en cualquier territorio nacional. Es posible lograr esto porque el servicio público desde un enfoque comunitario prioriza las relaciones sociales primarias sobre la base del respeto de costumbres, lo que permite trabajar con los miembros de una comunidad para el desarrollo de su bienestar integral.

Así mismo, en el contexto latinoamericano, si bien la realidad de implementar el enfoque comunitario de salud mental puede ser variada, el factor común es la implicancia de voluntad política y el trabajo basado en la corresponsabilidad. Así es como sucede en Colombia, donde la salud mental es abordada desde un enfoque diferente al comunitario a nivel nacional, pero la eficacia de casos puntuales donde se implementa este enfoque es valioso para considerar su replicación. Los autores Satizabal y Ortiz (2019) sostienen la postura de apostar por el enfoque comunitario, debido a que exponen que la situación de la salud mental en Colombia no avanza porque a pesar de que a inicios de los 2000 se dio una reforma psiquiátrica a nivel mundial que motivó la introducción de un nuevo enfoque,



la situación del servicio en Colombia persiste en el modelo institucional. Así mismo, esta persistencia en el enfoque institucional es injustificada pues va contra la Ley de Salud Mental legislada en el 2013 en Colombia, la cual favorece el derecho a la salud mental mediante el servicio público comunitario, por lo que este caso evidencia una ausencia de voluntad política por reformar el servicio.

En ese sentido, Satizabal y Ortíz (2019) exponen el caso particular de la Universidad del Valle, la cual con su iniciativa de brindar servicios psicológicos desde el enfoque comunitario ha funcionado por medio de la inclusión social y de la participación de estudiantes junto con docentes de diferentes especialidades. En dicho caso, atender la salud mental de la comunidad universitaria desde el enfoque comunitario ha logrado reflejar los aspectos positivos del enfoque, evidenciado en una mayor integración social y sentido de identidad sólido. Los autores esperan que tras el éxito de la implementación del enfoque comunitario en el ambiente académico, se logre motivar a innovar su política de salud mental históricamente institucional.

Consecuentemente, para reforzar la idea del enfoque comunitario como opción renovadora y posibilitadora de mejoras en la atención, Figler (2022) expone el caso específico de Casa club Baires en Argentina por seguir el modelo comunitario internacional validado por la OMS. Esta investigación ahonda en la importancia del enfoque comunitario, explora la característica de brindar servicios de salud mental desde la comprensión de la interrelación, la cultura común y el sentimiento de pertenencia. Y por el lado de los resultados, Figler (2022) destaca la contribución de aplicar este enfoque en el servicio de salud mental a las personas que son internadas en el Club Baires porque su integridad, sentido de pertenencia, bienestar y habilidades sociales aumentan al llevar sesiones grupales.

El aspecto peculiar de su investigación radica en que Figler (2022) resalta cómo el enfoque comunitario más que concentrarse en buscar enfermedades mentales, alienta a no encasillar a las personas en el cuadro sintomático de estas; por el contrario, apuesta por desarrollar la autonomía y la integración social, tal como sucede en Casa club Baires. De manera puntual, el autor puede atribuir la eficacia de este servicio a la ley argentina de salud mental del 2010, la cual instó a abordar la salud mental de manera interdisciplinaria.



Como se ha visto, la salud mental abordada desde un enfoque comunitario puede repercutir de manera positiva en la vida de los ciudadanos. De esa manera, Tafur, Quispe y Ayala (2023) sostienen que en el contexto peruano, la implementación del enfoque comunitario trajo consigo al proyecto más ambicioso para contener la salud mental del país: los Centros de Salud Mental Comunitarios, los cuales fueron la red principal de soporte de atención en el periodo crítico de la pandemia. Los autores analizan el desarrollo de la salud mental en Perú en el contexto de la pandemia tras el impacto de la reforma de salud mental en el 2015 que introdujo el modelo comunitario en los servicios psicológicos. De esta reforma consideran que la introducción del enfoque fue necesario para redefinir el servicio de atención. Y, reconocen que la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el Perú resultó complejo de proliferar dadas las circunstancias como el desarrollo económico medio y las crisis sociopolíticas constantes, pero a la vez son circunstancias comunes a nivel regional, lo que no impide su implementación. Así mismo, también señalan que apostar por este enfoque incluso en países con ingresos medios y bajos resulta imprescindible porque los desórdenes mentales tienen de igual manera, alta injerencia en países con dichos rasgos. Lo complicado puede resultar no ser el contar con limitado presupuesto, sino el buscar replicar programas o estrategias aplicadas en países de altos ingresos, sin considerar las características propias de la población, por ello, los autores argumentan a favor de una implementación de enfoque comunitaria sobre estrategias realistas para resultados efectivos.

En el Perú, uno de los elementos para considerar estrategias realistas en salud mental es el presupuesto, el cual es menos del 1% de lo destinado al sector salud. Ello implica limitaciones; y en el aspecto político, decisiones estratégicas como la reforma del 2015 sirvieron para abordar el problema de manera multisectorial y emprender un camino de transición del enfoque médico al comunitario. Para los autores Peña, González y Parada (2021), esta reforma fue un soporte positivo en crisis como la pandemia, puesto que los CSMC, los cuales operan bajo el enfoque comunitario, contribuyeron a frenar los efectos de la pandemia en la salud mental, atendiendo un aproximado de 40 mil personas en sus primeros cuatro meses.

En síntesis, los estudios revisados logran aportar una visión completa de lo que es el enfoque comunitario en la prestación de servicios de salud mental, sus implicancias para introducirlo en contextos nacionales con dificultades socioeconómicas y los efectos



por los cuales vale la pena apostar por conducir la salud mental nacional bajo dicho enfoque. Es así que Dávila (2020) introduce la comprensión integral de lo implica operar bajo un enfoque comunitario al sostener que se trata de trabajo multidisciplinario centrado en el crecimiento de la salud mental dentro de la comunidad, y con efectos que Montero (2004) direccionan la relación persona-comunidad hacia la participación y el compromiso, de ese modo no solo genera bienestar individual, sino que hay efectos positivos para el conjunto social. Así mismo, en los estudios de Peña, González y Parada (2021), exploran que los elementos que pueden limitar la implementación de un enfoque comunitario en la política de salud mental son las variables sociales y económicas, por ello dan énfasis en conocer las características nacionales y las particularidades del contexto propio para tomar decisiones precisas y aplicables a la realidad nacional en la cual se quiera insertar el modelo comunitario a fin de obtener resultados que no resulten ser objetivos imposibles en términos de presupuesto y que logren crear impacto en la sociedad. En esa misma línea, Ramos (2000) resalta que el enfoque comunitario puede resultar ser la herramienta de solución a una parte del problema de desigualdades dado que como parte de sus objetivos, se halla el mermar las disparidades e inequidad social existente mediante el trabajo de integración de los individuos a la sociedad.

Así mismo, Satizabal y Ortíz (2019) exploran las virtudes de este enfoque desde el caso particular de la Universidad del Valle para instar a su implementación como proyecto de escala nacional, pero acotan que gran parte de la materialización depende de la voluntad política de las autoridades estatales. Por lo que Figler (2022), considera ventajoso la transición temprana del enfoque clásico al enfoque comunitario a partir de la ley del 2010 en Argentina, cuya legislación permitió reforzar la atención pública, desde el fortalecimiento de vínculos sociales, y cuyo impacto ha traído resultados en la recuperación de los internados de la Casa Baires. De ese modo, Tafur, Quispe y Ayala (2023) también resalta que la implementación del enfoque comunitario tras la reforma de salud mental en 2015 en Perú, ha posibilitado la creación de redes fuertes (CSMC) para la contención de casos en contextos críticos como la pandemia. En conjunto, estas investigaciones sugieren que el enfoque comunitario no solo expresa un cambio en la mirada a la salud mental tradicional, sino que también supone un reto para el Estado en cuanto a la reestructuración del servicio tradicional. Esto último implica trascender las limitaciones socioeconómicas nacionales desde el compromiso y la voluntad política,



para gestionar la implementación eficaz de un enfoque comunitario en el servicio de salud mental pública que refuerce el sentido de ciudadanía–comunidad.

. Eje temático 3: Proceso e implicancias de la implementación de los CSMC a nivel de gestión pública.

Las investigaciones respecto a la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitarios han tenido un ajustado despliegue, pero con aportes precisos para contribuir al diálogo sobre la importancia de la relación e interacción genuina entre autoridades, ciudadanos y CSMC. Los centros de salud mental comunitarios (CSMC), son de modo conciso, la materialización de todos los esfuerzos en cuanto a políticas públicas en salud mental, por ello mismo, son el foco principal para la presente investigación. En ese sentido, se busca analizar el proceso de implementación de los CSMC desde el enfoque comunitario, donde la figura principal es la autoridad política y su capacidad de gestión para trascender las dificultades y generar resultados.

Entre los estudios que se han realizado en diferentes países, resalta el trabajo de Camas (2018), quien examina el caso ecuatoriano a partir de la situación crítica de salud mental en el país. Considera que lo cuestionable es el aspecto de la gestión pública, puesto que a pesar de que el modelo comunitario se introdujo en los servicios de atención primaria en salud hace una década, no se han dado los resultados esperados, por lo que es pertinente cuestionar qué o cuales son los factores que no permiten la prosperidad del modelo en Ecuador. Camas (2018) puntualiza que entre los principales motivos, el sistema de salud mental ecuatoriano presenta dificultades que limitan la implementación del enfoque y consecuentemente, los CSMC. Teniendo en cuenta ello, esas limitaciones se reducen a cuatro principales: el bajo presupuesto para el sector visto en la tendencia a dar un mínimo (1.46%) del mismo a la salud mental, lo preocupante de ello es que la mitad del mismo se destina a los hospitales psiquiátricos, y ello conduce a criticar acerca de la comprensión del sistema ecuatoriano sobre el enfoque.

Los otros tres puntos se reducen al cuerpo profesional insuficiente y no especializado, el cuarto limitante viene a ser la persistencia del modelo biomédico, el cual tras la evidencia del presupuesto, resulta una realidad en el sistema de salud ecuatoriano. Con dichos puntos expuestos, el autor considera importante el rol de las universidades para cambiar ese paradigma biomédico mediante proyectos de vinculación con la



colectividad. Esto implica la participación de los estudiantes en prácticas pre profesionales que no se orienten al modelo hospitalario, de modo que se altere el actual paradigma de las ciencias de la salud como ciencias basadas en la enfermedad. Camas (2018) sostiene que el Estado ecuatoriano presenta dificultades para cambiar de paradigma y eso se nota en los servicios de salud mental ofrecidos, de hecho, la implementación de los CSMC se ha pospuesto debido a ello. El caso ecuatoriano es un ejemplo certero de la relación entre la visión política sobre la salud mental y su incidencia en la calidad de los servicios.

En esa misma línea, los autores Minoletti, Sepúlveda, Gómez, Toro, Irrarázabal y Díaz (2018), exponen su análisis de la implementación de los CSMC en el caso Chileno, desde un enfoque de gobernanza. Sostienen que la gobernanza puede incidir en la implementación de este tipo de proyectos desde el análisis de cinco dimensiones de la gobernanza chilena, entre ellas, la importancia de la participación e involucramiento de los propios usuarios en la elaboración de políticas vinculantes a salud mental a fin de que estas puedan resolver necesidades reales de su sociedad. De ese modo, las demás dimensiones permiten a los autores destacar que la implementación sostenida de estrategias de gobernanza (planes nacionales de salud mental, regulaciones presupuestarias, capacitación de recursos humanos y desarrollo de sistemas de información) ha sido fundamental para expandir el acceso a la atención de salud mental comunitaria, reducir la influencia de los hospitales psiquiátricos y mejorar la calidad del servicio en Chile. Ello demuestra la importancia del rol de la gobernanza integrada y coherente en políticas públicas para cubrir o resolver todas esas dimensiones de las que son responsables las autoridades en su gobernanza y que finalmente impactan en los servicios públicos.

Es así que un caso particular del abordaje de salud mental en Chile, es expuesto por Vega (2023). En el caso anterior, los autores chilenos describen las dimensiones en la gobernanza que dificultan el acceso a servicios comunitarios, puesto que el foco es el gobierno y su capacidad de gestión pública, al sostener que la gestión es compleja pues no solo implica legislar, sino también esfuerzos de trabajo cooperativo con actores del mismo nivel y actores sociales como los usuarios.

Para este caso, Vega (2023) presenta las dificultades que supuso la transición de un centro policlínico a un CSMC. Sostiene que resulta difícil transicionar la atención en



el policlínico cuando desde el ámbito político, se refuerza la idea de que las limitaciones parten del financiamiento, recursos insuficientes, participación usuaria ausente por la nulidad de instancias, entre otros. Y desde el ámbito profesional, los resultados no se producen debido a la incomprensión de los especialistas sobre el modelo comunitario, se conduce a la repetición del patrón biomédico, y por ende, no se desarrolla el principio fundamental de dar un rol participativo al paciente en su recuperación. Es así como, el autor destaca que pese a una alta motivación profesional, la reconversión enfrentó importantes barreras estructurales, como falta de planificación previa, escaso apoyo administrativo, financiamiento limitado, insuficiente uso de sistemas de información y baja participación activa de los usuarios. Estos elementos obstaculizaron la conversión a CSMC, pese a contar con un equipo comprometido, lo que enfatiza la necesidad de fortalecer los componentes organizacionales y de gestión.

Para ir más de cerca con la realidad peruana, Díaz (2021) recoge información sobre el proceso de implementación de los CSMC en el Perú. Comprende que el Perú, así como otros países de la región, también se ve limitado por el aspecto del financiamiento, pero la diferencia radica en que el país ha tomado la iniciativa antes que otros, esto puede resultar importante puesto que si bien en el presente, los CSMC no cuenta con la cobertura nacional esperada debido al mismo tema del financiamiento, es un factor que puede solucionarse por la experiencia ganado en los últimos años. En el aspecto de la implementación, el Perú concibe de forma teórica que la atención de salud mental comunitaria de alta calidad se basa en los derechos humanos, salud pública, recuperación, efectividad de las intervenciones, red de atención comunitaria y experiencia de pares. Díaz (2021) considera que esos seis principios son comprendidos para el despliegue de los CSMC, pero expone que la comprensión acertada de los especialistas en salud mental, se ve superada por la gestión pública de los CSMC, es decir, desde el nivel de gobernanza se presentan dificultades como la falta una pauta estructurada que guíe el proceso. En ese sentido, alude a reconocer que la débil iniciativa e intervención por parte de organismos públicos de alta dirección; encargados de la gestión de los CSMC, no permite superar las expectativas sobre los centros. Entonces, la iniciativa y propuestas del personal médico no resulta un garante para la correcta implementación de los CSMC, lo es en cambio, el rol de las instituciones políticas y su nivel de participación en la gestión de los CSMC.



Por ello, en el contexto peruano, es incluso más demandante en la gestión pública, el implementar centros de salud mental con un enfoque que los insta a colaborar y articular su trabajo para la materialización de los objetivos en salud mental. Baldeon, Castañeda y Silva (2022) en su estudio, conciben que el comienzo del proceso particular de la implementación de los CSMC en el Callao, yace en la comprensión del modelo alternativo comunitario para brindar servicios de salud mental. En ese sentido, al ser el Callao, una región populosa, que extiende su red de cobertura en salud mental en sus cuatro hospitales y cuenta con cinco CSMC dispersos en Ventanilla baja, La perla, Sarita Colina, Mi Perú y Carmen de Legua, entienden que hay más demanda de atención y por lo tanto, se requiere una alta capacidad de coordinación para lograr cubrir la demanda de usuarios. Baldeon, Castañeda y Silva (2022) recogen en base a los usuarios entrevistados, que las principales dificultades que enfrentan los CSMC son la sobresaturación e insuficiencia de recursos presupuestarios, estos son problemas que también se presentan en CSMC de otros distritos. Para los autores, en el caso del Callao, estos problemas se presentan por la falta de diálogo que oriente a gestionar mejores políticas para los CSMC, se entiende del caso que si se enfocarán los esfuerzos políticos a desarrollar espacios para el diálogo entre los actores, se podría disipar las limitaciones vistas en los centros del Callao.

Los estudios revisados coinciden en que la implementación de CSMC en América Latina enfrenta desafíos estructurales que comprometen su sostenibilidad, en gran parte debido a deficiencias en la gobernanza y la gestión. Minoletti, Sepúlveda, Gómez, Toro, Irrázabal y Díaz (2018) destacan que una gobernanza sólida, con planificación estratégica, capacitación y sistemas de información, ha sido clave para los avances en Chile; sin embargo, experiencias como la de Vega (2023) evidencian que incluso con equipos motivados, la falta de planificación y apoyo administrativo puede obstaculizar transformaciones institucionales profundas. En el caso peruano, tanto Díaz (2021) como Baldeon, Castañeda y Silva (2022) muestran que la débil articulación intersectorial, la ausencia de mecanismos deliberativos y la limitada participación comunitaria continúan siendo barreras persistentes en la implementación de los CSMC. Por su parte, Camas (2018) propone una alternativa integradora al vincular a las universidades y la atención primaria como actores estratégicos para fortalecer el enfoque comunitario. En conjunto, estos estudios revelan que la efectividad del modelo y los CSMC no depende únicamente



de su diseño técnico, sino también del entramado institucional y participativo que lo sostiene, lo que exige repensar la gobernanza desde una lógica más colaborativa, descentralizada y culturalmente situada.

1.4. Cierre final

En conclusión, el análisis del estado del arte en torno a la salud mental desde las políticas públicas, el enfoque comunitario y la gobernanza para la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) revela un proceso en construcción, marcado tanto por avances significativos como por tensiones persistentes. Respecto a la salud mental desde las políticas públicas, se reconoce que las políticas públicas en salud mental han evolucionado desde perspectivas biomédicas hacia marcos más integradores y basados en derechos. Por ejemplo, Lopera (2012) y Echeverría (2014) cuestionan la conceptualización con la que se aborda la salud mental en los instrumentos internacionales, dado que impacta en las políticas respectivas de los Estados. Por su parte, Cano (2014) evidencia cómo en el Perú este derecho ha sido históricamente postergado por el Estado, y Palma (2019) añade que este abandono se agudizó durante el conflicto armado interno, donde el sufrimiento psicosocial de la población fue sistemáticamente invisibilizado.

Además, Torres, Castellanos, Vásquez y Chang (2021) en los estudios dan cuenta de la magnitud del problema epidemiológico, que exige una respuesta pública estructural, mientras que Hayakawa (2018) rescata el papel de las coaliciones promotoras en la agenda política de salud mental, revelando que los avances no han sido lineales ni exclusivamente institucionales. En contraste, Castillo y Cutipé (2019) analizan la implementación concreta de la reforma de salud mental peruana desde el 2013, mostrando avances significativos en cobertura, pero también los riesgos de una sostenibilidad limitada si no se fortalece la gobernanza. En conjunto, estos aportes permiten argumentar que el marco normativo y programático, aunque necesario, resulta ineficaz si no se acompaña de voluntad política sostenida, financiamiento adecuado y procesos de descentralización reales.

Respecto al enfoque comunitario de las políticas de salud mental, se refuerza la necesidad de una mirada holística que considere tanto los determinantes sociales como la participación activa de las comunidades. Trabajos como los de Peña, González y Parada



(2021) y Ramos (2000) subrayan que el enfoque comunitario solo puede materializarse si se fortalece el tejido social y se incorporan dinámicas de inclusión, diálogo y empoderamiento. Autoras como Montero (2004) y Dávila (2020) enfatizan que el trabajo con la comunidad no es solo un componente operativo, sino un posicionamiento ético y político. A ello se suman estudios de caso como los de Satizabal-Ortiz (2020) y Fligler (2022), que demuestran en la práctica el impacto positivo de proyectos comunitarios sostenibles en el bienestar psicosocial, que son promovidos desde un compromiso político respaldado por estrategias y acciones instadas desde las autoridades políticas.

Finalmente, acerca de la gobernanza y gestión de los CSMC, los estudios permiten comprender que la implementación del modelo comunitario no solo requiere voluntad política, sino también una estructura institucional articulada, participativa y descentralizada. Minoletti, Sepúlveda, Gómez, Toro, Irrázabal y Díaz (2018) y Vega (2023) muestran cómo la planificación, los recursos humanos y la coordinación interinstitucional son condiciones necesarias para el éxito del modelo. En el contexto peruano, tanto Díaz (2021) como Baldeon, Castañeda y Silva (2022) revelan cómo la falta de diálogo deliberativo, la fragmentación institucional y el centralismo obstaculizan la sostenibilidad del sistema. Por su parte, Baena (2018) plantea una vía alternativa al proponer alianzas entre atención primaria y universidades como agentes promotores del cambio.

En conjunto, los estudios evidencian que la consolidación de un modelo comunitario de salud mental en la región requiere no solo transformar servicios y discursos, sino también las lógicas de gestión, participación y poder que los sustentan. Para ello, instan a comprender el problema desde una lectura integral del poder, la ciudadanía y el bienestar, puesto que las políticas públicas deben repensarse desde un enfoque que reconozca a la comunidad no como objeto de intervención, sino como sujeto político, capaz de disputar sentidos y de co-construir formas más justas de cuidado colectivo.

7. MARCO TEÓRICO

La presente investigación se enmarca en la Ciencia Política, con énfasis en el análisis de la gestión pública en el ámbito de la salud mental comunitaria. En este marco, se hace una revisión de las bases teóricas sobre los objetos conceptuales en los objetivos de investigación, siendo el énfasis en los conceptos teóricos de voluntad política,



implementación de política pública social y valor público del enfoque comunitario. Consecuente a ello, se ha de tener en consideración los factores que la componen y su interrelación en el ámbito público de la salud mental.

De ese modo, en este apartado se discutirá sobre la literatura relacionada con los fenómenos mencionados, tal como la gestión pública moderna, como el modelo pertinente para brindar el servicio de salud mental público de enfoque comunitario y en esa línea, la gestión de los Centros de Salud Mental Comunitarios. Es así que se abordará la implementación de la gestión moderna en este sector teniendo en cuenta a diversos autores y componentes que serán el soporte argumental para identificar las limitaciones presentes en la gestión pública del presente caso y con base en ello, formular la identificación de los problemas y las oportunidades de mejora.

7.1. Voluntad política como condición indispensable para activar el compromiso estatal en la gestión pública y garantizar la implementación efectiva de políticas públicas orientadas al bienestar colectivo.

Dentro del escenario político, se suscita una dinámica que para Hobbes comienza con la renuncia de ciertas libertades humanas para el control y orden de estas por un ente supremo, el Estado; el cual mediante el acuerdo social ha de asumir responsabilidades para con sus ciudadanos, la denominada gestión pública. Esta dinámica de control y gestión se ha ido suscitando y replicando con más ahínco tras la Revolución francesa, y para el periodo actual, es una dinámica propia de los gobiernos democráticos.

Sin embargo, aun teniendo este pacto o acuerdo social entre Estado y sociedad, las actividades que el gobierno pueda emprender para velar por el bienestar de su territorio no están estrictamente garantizadas, más bien, son sujetas a la voluntad política del conjunto de actores que componen el Estado. Dicho factor contiene un carácter ambiguo en cuanto a la definición, por ello es preciso comprender su relevancia dentro de la compleja ingeniería institucional del Estado.

La voluntad política, de forma concisa, es el compromiso sostenido de tanto políticos como administradores; es decir, el cuerpo político dentro del Estado, de invertir recursos políticos para lograr objetivos específicos (Rose and Greeley, 2006). Es como se planteó al comienzo, parte de la dinámica de acuerdo social entre Estado y sociedad, que parece estar intrínseco en la labor de gobierno, en una especie de carácter intrínseco



y no deliberativo, por lo que es menester esclarecer que la voluntad política ha sido tomada como un fenómeno prescindible evidenciado en la escasez de estudios sobre ella, mas para comprender su contenido teórico sí existe variada conceptualización.

Para los autores Lori A. Post, Amber N. W. Raile, and Eric D. Raile (2010), la voluntad política es un concepto complejo y multifacético compuesto de varios subconceptos, por lo tanto, llegaron al acuerdo de que dichos subconceptos colisionan dentro de tres categorías, siendo la primera la distribución de preferencias con respecto al resultado de interés, la cual engloba a los conceptos que enmarcan a la voluntad política en un contexto de surgimiento tras la puesta en escena de intereses. La segunda categoría es la autoridad, capacidad y legitimidad de los principales encargados de la toma de decisiones o de los reformadores, en esta categoría colisionan los subconceptos que unen de forma estricta a la voluntad política con los resultados políticos, de modo que la idea central de la categoría es el poder político y otros recursos que dependen de la capacidad del mismo actor político. En la tercera categoría se valoran las nociones de voluntad política en torno al compromiso con las preferencias, como es evaluar los incentivos y desincentivos que enfrentan los tomadores de decisiones para adoptar una posición particular.

Es así que, en las tres categorías se aúnan varias concepciones adoptadas por autores para definir la voluntad política, tras reconocer la complejidad del concepto, los autores consideran que la voluntad política, es, en términos sencillos, el grado de apoyo comprometido entre los principales tomadores de decisiones o actores políticos para una solución política particular a un problema particular, hacen énfasis en la variable del “grado” de apoyo para la solución política, pues en esta reconocen la distribución de preferencias específicas, una de las tres categorías comunes ya identificadas por ellos.

Para concluir con los aportes de Lori Ann Post, Amber Raile y Eric Raile, están descritas detalladamente sus apreciaciones sobre la voluntad política en su artículo “Defining political will” (2010), de estas se identifica que los autores argumentan a favor del concepto de la voluntad política como un proceso político que involucra preferencias agregadas de manera compleja de un gran número de actores políticos y que depende en gran medida del contexto, pero que no se puede reproducir en contextos donde persista la voluntad individual, esta es incompatible con la voluntad política por naturaleza. Entonces, adoptan el “enfoque agregado” por el cual definen la voluntad política como



un "esfuerzo colectivo", dado que, a pesar de la naturaleza individualista del ser humano, este se superpone a esa característica para obrar en función de su comunidad que forma un colectivo político.

De estas definiciones, sale a colación que la voluntad política trasciende el acuerdo y actividad racional entre actores, es sugestionada también a componentes subjetivos como la personalidad. Entonces, los rasgos de personalidad, las necesidades y los motivos, los valores, las opiniones sociales y la evaluación de la eficacia personal comprenden elementos relevantes dentro de no solo la personalidad individual para con uno mismo, sino, la personalidad política del individuo que opera en diferentes niveles y cuyos elementos operan en diferente medida para activarlo en el nivel político (Caprara, Vecchione, 2013).

Y una vez dadas las actividades producto de la voluntad política, es sencillo olvidar que existe tal fenómeno, pues esta normalmente no se encuentra como objeto de discusiones por ser concebida como el aire que se respira, algo que debería resultar tan natural que es pasado como desapercibido o se da por hecho dentro de la actividad política, puesto que cualquier acto político es producto precisamente de la voluntad política. Para Hambergren (2010), adquiere un rasgo naturalista, al punto que solo cuando se da la asfixia, nos percatamos de la ausencia de ella, esta comparación de la voluntad política con el aire sirve para confirmar la posición de Hambergren, que caracteriza a la voluntad política como la condición "sine qua non" del éxito de una política, que solo se percibe ante su ausencia.

Es esta concepción la que tomó la voluntad política dentro del análisis de la gestión pública de los centros de salud mental comunitarios, dado que en el intento de hallar causas primeras, la voluntad política se hace presente por su tendencia a la ausencia en la gestión de dichos centros, escenario donde sale a colación la falta de esfuerzos para lograr superar las deficiencias de los diversos centros a nivel nacional y sobre todo, superar las expectativas de demanda ciudadana en cuanto a la calidad del servicio.

Es así que de lo expuesto por diversos autores acerca de la voluntad política, es viable coincidir con que es la disposición real y sostenida de los actores del poder público para impulsar, implementar y sostener acciones orientadas al bien común. De acuerdo con Grindle (2007), la voluntad política se manifiesta cuando los tomadores de decisiones están dispuestos a asumir costos políticos, administrativos o presupuestarios en favor de



una política pública determinada. Y ello no solo basta con la formulación normativa; se requiere una alineación práctica entre discurso, decisiones y acciones concretas, se puede sostener que para afirmar la existencia de voluntad política, deben haber acciones que lo avalen y sean visibles para el público.

Uno de sus rasgos más característicos, es el compromiso institucional, el cual implica el grado en que las autoridades locales, regionales o nacionales adoptan como propia la promoción de la salud mental comunitaria. Este compromiso se expresa en decisiones formales (planes, ordenanzas, convenios interinstitucionales) e informales (discursos públicos, liderazgo, respaldo político). Según Hall (1993), las instituciones son reflejo de las ideas y prioridades dominantes en el sistema político, por lo que el compromiso hacia determinados temas se ve en su traducción institucional concreta.

Asimismo, O'Donnell (1993) sostiene que un Estado democrático debe mostrar un "compromiso operativo" con los derechos fundamentales, y la salud mental es uno de ellos. Desde esta perspectiva, el compromiso institucional es condición necesaria para la eficacia de las políticas sociales, y de ese modo, contribuye a la expresión de la voluntad política.

Por esa misma línea, cabe resaltar que la asignación de recursos es una expresión material de la voluntad política, por lo que es imprescindible su relación con este fenómeno. Dado que no puede hablarse de compromiso si no se respalda con presupuesto, personal y soporte logístico. Tal como señala Wildavsky (1964), "el presupuesto es la política hecha realidad", pues refleja las verdaderas prioridades de un gobierno más allá del discurso.

Y esto, en el contexto peruano, se puede traducir en que la implementación del modelo comunitario de salud mental depende en gran medida del financiamiento descentralizado y del interés de los gobiernos subnacionales en canalizar recursos hacia los Centros de Salud Mental Comunitarios (MINSA, 2022). Si bien existen normas técnicas y presupuestos programáticos, su ejecución es irregular y muchas veces depende del liderazgo local.

Continuando con otro rasgo clave para la evidencia de voluntad política, es innegable que la inclusión de los temas o problemas, en este caso la salud mental, en la agenda pública es otro indicador clave de voluntad política. Para Kingdon (1995) resulta que las políticas se vuelven viables cuando confluyen tres corrientes: el problema, las



soluciones y la voluntad política de los tomadores de decisión. De ese modo, si un tema como la salud mental no es visibilizado, no se convierte en política prioritaria. Y este indicador de voluntad política es pertinente en tanto tiene cabida en el contexto peruano, donde la salud mental ha tenido históricamente una baja visibilidad pública, aunque en los últimos años ha ganado mayor atención gracias a normativas como la Ley N° 30947. No obstante, priorizarla en la agenda requiere más que leyes: implica presencia sostenida en los discursos, planes de gobierno, medios locales y mecanismos de concertación.

Por ende, de la complejidad de este fenómeno, cabe enunciar que la falta de voluntad política, es más que la falta de determinación de un gobierno; para Beridt Knudsen (2013) sus consecuencias son devastadoras para el desarrollo y bienestar del país, la ausencia de esta solo demuestra, la falta de compromiso del actual gobierno peruano, su escasa disposición para abordar problemas urgentes y carencia de liderazgo decisivo. Dichos componentes que Knudsen indica como carentes en la política del país, son los mismos expuestos por Lori Ann Post, Amber Raile y Eric Raile (2010) como componentes clave de la voluntad política, por lo que se puede asumir que, a grandes rasgos, desde el núcleo del gobierno central se produce una débil voluntad política, que se ve replicada en ámbitos de gestión específicos como la salud mental.

7.2. La implementación de la política social de salud mental con enfoque comunitario como dinámica institucional basada en estrategias, acciones y condiciones.

Las políticas públicas de carácter social constituyen un conjunto de decisiones y acciones deliberadas del Estado orientadas a la satisfacción de necesidades sociales y a la promoción del bienestar colectivo (Dye, 2013). Desde una perspectiva conceptual, Kraft y Furlong (2013) definen las políticas públicas como los cursos de acción o inacción adoptados por los gobiernos para responder a problemas sociales específicos, enfatizando que la política social busca garantizar derechos y reducir desigualdades estructurales. En esa misma línea, (Laubier, 1984; Garretón, 2001) entienden a la política social como el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, promoviendo derechos sociales y bienestar.

De manera más enfática, Garretón (2001), realza la necesidad de contar con políticas públicas de carácter social pues afirma que la política social busca producir en



la sociedad, el acceso a derechos, igualdad y ciudadanía activa, de ese modo, la política social no solo genera resultados de gran impacto para la sociedad, sino que también construye una relación cercana y espontánea entre el estado y la población, de esa manera se producen dinámicas que permiten al Estado conocer la realidad nacional y gestionar la solución efectiva de problemáticas sociales.

En este sentido, Pisfil (2006) distingue entre una visión macro, que contempla la interacción entre Estado y sociedad, y una visión micro, que se enfoca en las acciones concretas del gobierno para alcanzar objetivos sociales, la distinción resulta útil para comprender la complejidad de implementar políticas públicas. Asimismo, se coloca en el contexto nacional para analizar que las políticas públicas en el Perú mantienen un esquema tradicional de planeación y ejecución, caracterizado por una fuerte burocratización y fragmentación institucional, lo que limita su eficacia y capacidad de respuesta a problemas complejos. Por ende, sostiene que existe una separación significativa entre el Estado y la sociedad civil, lo que dificulta la articulación y legitimidad de las políticas públicas (Pisfil, 2006). Esto enfatiza la necesidad de superar esta separación a través de una mayor participación ciudadana y de mecanismos que permitan la inclusión de diversos actores sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, promoviendo así una gobernanza más democrática y efectiva.

Otra premisa relevante es que la implementación de nuevas políticas públicas requiere un enfoque articulado que integre dimensiones sociales, económicas e institucionales, que reconozcan la complejidad de los problemas (Pisfil, 2006). Esto implica que las políticas sociales, incluida la salud mental comunitaria, deben ser diseñadas y ejecutadas con una visión integral y coordinada.

En esa línea, es pertinente señalar que Ingram y Schneider (2007) aportan que, en cuanto al diseño de las políticas públicas, la construcción social de las poblaciones objetivo es fundamental para comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, ya que estas construcciones influyen en la definición de prioridades y en la asignación de recursos. Por tanto, la política social no solo es un conjunto de medidas técnicas, sino también un proceso dinámico que refleja relaciones de poder y contextos socioculturales. Además, el marco analítico de los autores, subraya que las políticas públicas son instituyentes, es decir, producen cambios en las relaciones de poder y en la construcción social de los grupos objetivo. Esto significa que las políticas no solo tienen efectos



prácticos o materiales, sino también efectos simbólicos que legitiman o deslegitiman a ciertos grupos y prácticas sociales (Ingram & Schneider, 2005), lo cual es importante si se desea aplicar en un contexto donde la población es vulnerable y la problemática a resolver es una invisibilizada, tal como lo es la salud mental.

Por otro lado, en el ámbito específico de la salud mental, el enfoque comunitario ha emergido como una alternativa al modelo biomédico tradicional, que se centraba en la institucionalización y el tratamiento hospitalario (Minoletti y Zaccaria, 2005). Este enfoque promueve una atención integral, centrada en la comunidad, que reconoce la importancia de los determinantes sociales y la participación activa de los actores locales (Bang & Stolkiner, 2014). Entre sus principios fundamentales destacan la promoción de la participación comunitaria, la transformación de los lazos sociales, el respeto a los derechos humanos y la intersectorialidad en la gestión de políticas (Velázquez y Seminario, 2017).

De manera explícita, Bang y Stolkiner (2014), destacan la participación activa de la comunidad, la transformación de los lazos comunitarios hacia vínculos solidarios y la constitución de la comunidad como sujeto activo de transformación social como uno de los principios esenciales del enfoque comunitario. De ese modo, comprenden que el enfoque se basa en principios esenciales como la participación activa de la comunidad, dado que la comunidad es sujeto activo en la identificación de necesidades, diseño y ejecución de intervenciones, y no solo receptora de servicios. Además orienta la transformación de los lazos comunitarios, dado que busca fortalecer los vínculos solidarios y la capacidad de la comunidad para afrontar colectivamente los problemas de salud mental. Asimismo tiene un enfoque en los derechos, ya que el modelo comunitario integra el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, superando la lógica de exclusión. Sumado a eso, se rige por la intersectorialidad, pues la política social de salud mental requiere la articulación de múltiples sectores (salud, educación, justicia, trabajo, sociedad civil) para abordar los determinantes sociales del malestar psíquico. De ese modo, se colige el carácter integral del enfoque y su vínculo con los objetivos de una política social de salud mental para la atención integral de los ciudadanos.

Respecto a las estrategias institucionales para implementar este enfoque, estas incluyen el desarrollo de redes comunitarias de apoyo, la promoción y prevención en



salud mental, la descentralización de servicios hacia dispositivos territoriales y la inclusión de usuarios y familias en los procesos de diseño y evaluación (Vitelleschi & Muñoz, 2023). Estas acciones buscan no solo atender la problemática individual, sino también fortalecer la capacidad colectiva para afrontar el malestar psicosocial.

No obstante, la implementación efectiva de políticas sociales de salud mental con enfoque comunitario requiere condiciones institucionales específicas. La voluntad política y el liderazgo son esenciales para impulsar y sostener los cambios necesarios (Pisfil, 2006). Asimismo, es indispensable contar con recursos humanos capacitados, financiamiento adecuado y un marco normativo claro que respalde las acciones (Minoletti & Zaccaria, 2005). Otro factor clave para la viabilidad y sostenibilidad de la implementación es la evaluación participativa y el monitoreo continuo, dado que permiten ajustar las estrategias y garantizar su pertinencia en contextos locales diversos (Bang & Stolkner, 2014). Un ejemplo que representa la materialización de esta política social es la creación y consolidación de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), los cuales para Minoletti y Zaccaria (2005) son dispositivos descentralizados que acercan la atención especializada a la población, integrándose con las organizaciones locales y con un conocimiento profundo de la realidad territorial. Estos centros integran los principios del enfoque comunitario y su alcance en materia de salud mental es presto a replicarse en contextos territoriales diversos.

En América Latina, países como Perú, Argentina y Chile han avanzado en la transición hacia modelos comunitarios de salud mental, enfrentando desafíos como la desigualdad territorial, la resistencia institucional y la necesidad de fortalecer la participación social (Velázquez & Seminario, 2017; Vitelleschi & Muñoz, 2023). Estas experiencias evidencian que la política social en salud mental es una dinámica institucional compleja, que requiere la articulación de múltiples actores y la adaptación constante a las condiciones sociales y culturales.

En conclusión, la política social de salud mental con enfoque comunitario se configura como una dinámica institucional compleja basada en estrategias participativas, acciones intersectoriales y condiciones que favorecen la inclusión, el respeto de derechos y que busquen transformar la atención y promoción del bienestar psicosocial desde una perspectiva integral y participativa. La literatura especializada y las experiencias regionales ofrecen un marco teórico sólido para comprender y fortalecer este proceso de



cambio hacia la implementación de un enfoque integral en salud mental como lo es el enfoque comunitario.

7.3. El valor público como expresión de satisfacción, legitimidad y pertinencia del servicio comunitario en salud mental.

La categoría de valor público es la última piedra angular para el desarrollo de una gestión eficiente en el CSMC, puesto que permite comprender los efectos sociales, simbólicos y políticos de una política o servicio público desde la perspectiva de los ciudadanos. En el enfoque de gestión pública moderna, este concepto trasciende la noción de eficiencia administrativa: se trata de generar bienes colectivos que respondan a las necesidades reales de la población y fortalezcan la relación entre Estado y ciudadanía.

Según Moore (1995), el valor público se crea cuando los gobiernos satisfacen las expectativas ciudadanas, actúan con legitimidad y usan los recursos públicos de forma eficiente. Así, el centro de atención no es solo el cumplimiento de metas operativas, sino el impacto positivo y tangible que las políticas tienen sobre la vida de las personas. En el caso de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), como el de Pueblo Libre, esta categoría es clave para evaluar si el enfoque comunitario, bajo el que opera el centro, realmente se traduce en beneficios reconocidos y valorados por la comunidad.

En tal sentido, cabe exponer el contexto del enfoque comunitario de la salud mental para luego dar con su implicancia en el valor público. En primer lugar, dentro del ámbito de la salud mental tal como en el ámbito de la gestión pública, se produjo un proceso de transición interna, el cual consistió en el salto de un enfoque biomédico a un enfoque comunitario debido a influencia internacional en este ámbito por parte de la OMS y otros países de la región; y, debido a razones nacionales como el contexto social inestable de la época de inicios de los 2000, que demandaba una forma más efectiva para brindar el servicio de salud mental.

Por medio de este enfoque, se da el protagonismo a los actores sociales, de modo que constituyen un aspecto central para la distribución del poder y la recuperación de derechos de ciudadanía, el proceso en sí mismo es de carácter participativo, lo que permite comprender el rol de la facilitación comunitaria hacia la reconstrucción de lazos asociativos y acciones colectivas en salud mental (Cea, 2019).



Sin olvidar la cuestión central, el enfoque comunitario considera a la salud mental como signo de salud integral enfocado en el bienestar del ser humano, el cual es inseparable de su entorno comunitario puesto que es importante reconocer la historia de vida de la persona que recibe servicios de salud mental, para de esta manera ofrecer un tratamiento efectivo, de ese modo, el trabajo comunitario en salud mental que pauta el enfoque comunitario es más que una política, es una necesidad (Dávila y Mercado, 2020).

De forma precisa, el enfoque comunitario de salud mental es el ofrecimiento de una amplia formación de servicios, programas y facilidades para que toda persona que esté buscando ayuda, pueda encontrar estos servicios desde sectores sociales como la escuela, el trabajo, juntas vecinales y otros, de modo que el acceso es más sencillo y cercano a la población, esto mismo, responde a la noción unitaria del enfoque comunitario sobre el grupo o comunidad. Entonces, es viable producir resultados sobre esa base compuesta de relaciones sociales que van creando redes con otros actores sociales, todos dentro de una misma comunidad, donde se concientiza, previene y trata problemas de salud mental.

Además, sobre este enfoque, el Ministerio de Salud (Minsa) acota lo siguiente en los Lineamientos de Política sectorial en salud mental:

El modelo de cuidado en salud mental comunitaria es la forma diferente de organizar los servicios de salud mental, que parte de las concepciones de la persona, como un ser integral de carácter multidimensional, biopsicosocial y espiritual; y, de la salud, como un bien social que se produce en el escenario natural de cualquier persona, familia o comunidad. Por lo tanto, dicho modelo rompe las dicotomías relacionadas a lo individual/social y a lo biológico/psicológico, así como a las hegemonías culturales (Ministerio de Salud, 2018).

Se apuesta entonces, por un enfoque comunitario, dando menor grado de valor al modelo biomédico - hospitalario, para revalorar a la comunidad y su rol activo en la recuperación. En esa línea, en base a lo expuesto, se concluye que el enfoque comunitario es necesario para resultados efectivos a nivel de salud mental, este enfoque evita la estigmatización del usuario, no lo encapsula en un diagnóstico y no lo aleja de la sociedad para internarlo, por el contrario, se enfoca en su integración dentro de su comunidad, esto es posible porque el enfoque comunitario busca dispersarse en el territorio a modo de establecer redes de apoyo locales a través de instituciones públicas, centros educativos, y



otros, para así brindar el servicio de la mano del ejercicio de los derechos humanos. De ese modo, es entendible que, mediante este enfoque, el cual se alinea con brindar servicios desde una percepción completa de la integridad del ser humano, se puede generar valor público, el cual es el sustento a perseguir de toda política nacional.

Para Blaug (2006), el valor público es “aquello que el público valora”, y para generarlo se ha de tener en cuenta las preferencias, intereses y necesidades de los ciudadanos, de modo que, si se busca impartir bienes o servicios brindados y dispuestos a generar valor público, estos deben responder a criterios de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. La cuestión vinculante entre este aspecto y el enfoque comunitario, es que este último es impulsado por una gestión pública moderna.

De modo, que para Zegarra, Olano, Lluncor y Cacho (2021), el estado busca modernizarse haciendo prevalecer el servicio a brindar para la población, y se innova porque desde décadas pasadas, los resultados de la gestión tradicional no fueron los óptimos, ya que justamente difieren de la nueva gestión pública, sobre la base de lo mencionado, ellos buscan señalar al valor público como característica fundamental en la nueva gestión pública. De lo mencionado, se colige que el valor público es el resultado que buscan la gestión moderna, y por ello mismo, es un escenario presto para la interacción entre todos los factores que se han ido exponiendo, entre ellos el enfoque comunitario.

Continuando, acerca de la base teórica del valor público, una de las primeras expresiones de este es la experiencia directa de los ciudadanos con los servicios ofrecidos. Ello quiere decir, que la satisfacción no debe limitarse a la calidad técnica del servicio, sino también incluir aspectos como el trato recibido, la accesibilidad, la oportunidad de la atención y la sensibilidad cultural del personal.

Acerca de ello, autores como Bouckaert y Van de Walle (2003) destacan que la percepción ciudadana constituye un insumo indispensable para evaluar los servicios públicos, ya que permite identificar no solo deficiencias técnicas, sino también distancias simbólicas entre el Estado y la comunidad. Esta dimensión es particularmente relevante en servicios como los CSMC, donde la atención implica una relación de cuidado, confianza y continuidad.

Asimismo, para generar valor público, los servicios deben ajustarse a las necesidades reales y sentidas de la población. Como sostiene Pollitt (2006), una



administración pública moderna no puede ignorar la “voz del usuario” si busca legitimarse y mantenerse sostenible en el tiempo, de ese modo, se considera crucial pensar en satisfacción y percepción del usuario si se busca generar valor público.

Otra de las expresiones más relevantes de este punto es la legitimidad y confianza que se pueda generar, la cual avala si se produce realmente el valor público, dado que también se construye cuando las instituciones generan confianza y reconocimiento social. La legitimidad institucional no se impone, se construye a través del desempeño, la cercanía con la ciudadanía y la percepción de que las decisiones responden al interés colectivo.

Tal como lo plantea Rothstein (2011), los ciudadanos tienden a confiar más en las instituciones cuando las perciben como imparciales, accesibles y competentes. En ese sentido, la legitimidad del CSMC se refleja en el grado en que la comunidad lo reconoce como un actor necesario, confiable y útil para el bienestar colectivo.

Además, la legitimidad no es estática: debe renovarse continuamente mediante prácticas transparentes, mecanismos de participación y respuestas oportunas a las demandas. Si el centro logra posicionarse como un espacio accesible, respetuoso y comprometido, contribuye a fortalecer el contrato social entre Estado y ciudadanía.

Y por último, es necesario demostrar la contribución al bienestar colectivo cuando se habla de valor público, puesto que este se materializa cuando un servicio público mejora las condiciones de vida de la comunidad, fortalece sus vínculos sociales y promueve la inclusión. En el caso de la salud mental, esto implica no solo tratar enfermedades, sino reducir el estigma, fomentar la solidaridad y construir redes de apoyo que promuevan el bienestar emocional colectivo.

Por ejemplo, como se señaló anteriormente, para Dávila y Mercado (2020), el enfoque comunitario en salud mental permite trabajar con las personas en su entorno cotidiano, generando acciones de prevención, promoción y acompañamiento que fortalecen el tejido social. Por ello, el impacto de un CSMC debe medirse también en términos de cohesión social, empoderamiento ciudadano y reconstrucción de la confianza colectiva, estos vendrían a ser de manera precisa, los aportes directos del enfoque que garanticen el valor público de un proyecto público como el CSMC. Desde la Ciencia Política, esta dimensión sobre la contribución refuerza la noción de valor público como



bien relacional: no es un producto que se entrega, sino una construcción colectiva que surge cuando Estado y comunidad trabajan juntos para transformar realidades.

De manera conclusiva, el valor público es complejo e inherente en el enfoque comunitario, por lo que se entiende la relevancia del enfoque, y aún más, el sentido urgente de garantizar el valor público con la gestión moderna de políticas sociales, a fin de no solo entregar un servicio, sino que este contribuya de manera positiva al bienestar colectivo, lo cual puede ser beneficiosos tanto para el estado como la ciudadanía, pues se refuerzan lazos entre ambos como la confianza, y el resultado final se traduce en un cambio positivo en la calidad de vida de los ciudadanos que demandan el servicio de salud mental.

8. HIPÓTESIS

1.1. Hipótesis general

- La calidad de la implementación del enfoque comunitario en el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” está condicionada por un conjunto de factores político - institucionales como la voluntad política y la implementación adecuada de la política social. En ese sentido, la consolidación del enfoque comunitario requiere de factores políticos e institucionales consistentes, cuya presencia , o ausencia, tiene un impacto directo en la capacidad del centro para generar intervenciones pertinentes y lograr la satisfacción de los usuarios con el servicio recibido.

1.2. Hipótesis específicas

- La voluntad política institucional-sectorial del Ministerio de Salud y de la DIRIS Lima Centro ha tenido un rol determinante en la implementación del enfoque comunitario en el CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre durante el periodo 2018–2025. Este respaldo político se manifiesta en la formulación de diferentes documentos institucionales y recursos; por lo tanto, la existencia, o ausencia, sostenida de estas acciones ha condicionado la capacidad del centro para desarrollar intervenciones comunitarias pertinentes y sostenidas, afectando directamente la profundidad y calidad con que se implementa el modelo de atención comunitaria.



- Se presume que la manera en que el equipo profesional del Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado' implementa las estrategias y mecanismos de participación comunitaria, así como los factores que condicionan dicha implementación, como los recursos disponibles o las dinámicas institucionales, inciden en los resultados y alcances efectivos de la política social de salud mental con enfoque comunitario.
- La implementación efectiva del CSMC de Pueblo Libre contribuye a la generación de valor público, reflejado en una mayor satisfacción de los usuarios, fortalecimiento de la confianza institucional y mejoras en el bienestar colectivo, este impacto real y socialmente percibido del CSMC no se mide solo por cobertura o atención clínica, sino por su capacidad de producir bienes públicos valorados por la comunidad.

9. METODOLOGÍA

9.1. Enfoque

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por centrarse en la comprensión profunda de fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores involucrados. Este enfoque no busca medir variables ni generalizar resultados estadísticos, sino interpretar significados, dinámicas y relaciones en contextos específicos. Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de captar la complejidad del entorno social, el uso de técnicas flexibles de recolección de información, y la capacidad de generar conocimiento contextualizado y reflexivo (Hernández et al., 2014). Además, se enmarca en una orientación interpretativa o comprensiva, propia de las ciencias sociales, donde el objetivo principal es reconstruir el sentido que los sujetos otorgan a sus acciones dentro de un entramado institucional o político determinado (Taylor y Bogdan, 1990).

Consecuentemente, dado que esta investigación analiza la implementación del enfoque comunitario de salud mental y la voluntad política institucional-sectorial en el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”, el enfoque cualitativo resulta pertinente por dos razones principales. Primero, porque permite explorar las percepciones, experiencias y prácticas de los actores involucrados, tanto personal del



CSMC como representantes del sector salud, lo que resulta fundamental para comprender cómo se configura y sostiene el enfoque comunitario en la práctica. Segundo, porque este enfoque facilita el análisis interpretativo de documentos institucionales y normas, lo cual es esencial para reconstruir el respaldo político e institucional hacia el modelo comunitario en el periodo 2018–2025. Sumado a ello, el análisis se realiza desde un enfoque interpretativo o comprensivo, el cual compatible con los estudios de Ciencia Política aplicada al campo de políticas públicas.

9.2. Alcance

El alcance de la presente investigación es descriptivo porque este se enfoca en caracterizar, detallar y sistematizar las propiedades, cualidades o relaciones de un fenómeno social, utilizando criterios sistemáticos que permiten registrar, analizar e interpretar datos de manera precisa y objetiva, para poder proporcionar información sistemática y verificable que ayuda a comprender el tema estudiado (Guevara et al., 2020). Asimismo, este tipo de alcance busca identificar patrones, comportamientos o estructuras dentro de contextos concretos, sin modificar las variables estudiadas ni intervenir en los hechos observados, es por ello que los estudios descriptivos permiten obtener información precisa y organizada sobre personas, grupos o situaciones, lo cual facilita el análisis comparativo y la generación de conocimientos aplicados (Sampieri et al, 2014). En el campo de la Ciencia Política, este alcance permite construir una imagen precisa y estructurada de la realidad política, a la vez que brinda información detallada y sistemática que facilita la comprensión del contexto

Este alcance resulta pertinente para la presente investigación porque permite registrar y describir de manera sistemática cómo se implementa el enfoque comunitario en el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”, a través de sus estrategias, dinámicas participativas y condiciones institucionales. Asimismo, también es adecuado porque permite documentar las percepciones y valoraciones de los actores entrevistados, profesionales de salud y usuarios, en torno a la prestación del servicio, lo cual enriquece la comprensión de los elementos que configuran la calidad de la atención desde una perspectiva contextual y situada.

Asimismo, el alcance es explicativo, puesto que este se caracteriza por identificar las causas, relaciones o factores que influyen en la ocurrencia de determinados fenómenos



sociales. Se orienta a responder al “por qué” y al “cómo” de los hechos, centrándose en establecer vínculos significativos entre variables o dimensiones de análisis. De modo conciso, los estudios explicativos pretenden esclarecer los mecanismos causales que generan un fenómeno, así como las condiciones bajo las cuales este ocurre (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además, en el campo de las ciencias sociales, este tipo de investigaciones permite comprender de forma profunda las estructuras, relaciones de poder y procesos que dan origen o sostienen determinadas prácticas institucionales o sociales (Rubio, 2012). Y precisamente aquellas temáticas son compatibles con la información que se analiza en la investigación

En síntesis, este enfoque resulta pertinente para la presente investigación porque, en primer lugar, busca interpretar de qué manera la voluntad política institucional-sectorial incide en la implementación del enfoque comunitario en salud mental, para ello beneficia el análisis de cómo las decisiones normativas, presupuestales y operativas de los actores del sector salud condicionan su aplicación en el CSMC “Honorio Delgado”. Y en segundo lugar, este alcance permite explorar las relaciones causales desde un enfoque cualitativo e interpretativo, en tanto se reconstruyen procesos complejos que vinculan actores, niveles de decisión y efectos sobre la calidad del servicio, sin necesidad de establecer correlaciones estadísticas, pero sí comprensiones profundas sobre causalidades sociales.

9.3. Método

El método adoptado en esta investigación es el estudio de caso, una estrategia metodológica que permite analizar fenómenos sociales complejos dentro de su contexto real a través de una recopilación detallada de datos con varias fuentes de evidencia, esto proporciona una visión profunda y precisa del objeto de estudio al ofrecer descripciones detalladas y generar relaciones causales. Como se menciona, este método se caracteriza por el uso intensivo de múltiples fuentes de evidencia y por su capacidad para generar descripciones profundas, reconstruir procesos y explorar relaciones causales interpretativas (Yin, 2003). Desde un enfoque cualitativo, el estudio de caso contribuye a identificar dinámicas sociales, políticas e institucionales con un alto grado de especificidad y contextualización. En el campo de la Ciencia Política, este método ha sido ampliamente utilizado para comprender fenómenos políticos concretos, generar teoría



empírica o aplicar conceptos abstractos en escenarios reales, ya que permite captar la complejidad de los procesos sociales en territorios y momentos específicos (Jiménez, 2012). En ese sentido, el estudio de caso es especialmente útil para captar la complejidad de las relaciones entre actores políticos, especialistas y ciudadanos, y para explorar los factores que influyen en la implementación efectiva de políticas públicas en contextos locales.

De ese modo, el estudio de caso es pertinente para esta investigación por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque permite un análisis profundo y situado del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”, delimitado en un contexto institucional, territorial y temporal concreto (Pueblo Libre, 2018–2025), lo que favorece la comprensión de cómo se implementa una política pública específica desde una lógica sectorial y comunitaria. Y en segundo lugar, este método posibilita examinar de manera articulada la interacción entre voluntad política institucional-sectorial e implementación del enfoque comunitario, a partir de evidencias empíricas obtenidas mediante entrevistas y análisis documental, lo cual contribuye a generar hallazgos relevantes tanto para la teoría como para la práctica en políticas sociales. Dados esos motivos, el estudio de caso aporta en primera instancia, el análisis contextualizado de un fenómeno real y particular, y favorece la articulación entre teoría y realidad, ya que permite aplicar conceptos como “voluntad política” o “valor público” a una realidad concreta, y observar cómo se manifiestan o se sostienen en la práctica institucional.

9.4. Técnicas e instrumentos

Una de las técnicas utilizadas en esta investigación es el análisis documental, el cual consiste en la revisión sistemática, crítica y estructurada de fuentes escritas y oficiales con el fin de recolectar datos pertinentes para el estudio. Esta técnica permite acceder a información consolidada, comparar lineamientos institucionales y establecer relaciones entre los marcos normativos, presupuestales y operativos vinculados a un fenómeno (Álvarez-Gayou, 2003). Asimismo, permite contrastar las declaraciones institucionales con las prácticas observables, lo cual contribuye a validar hallazgos provenientes de otras fuentes como entrevistas. En el ámbito de las políticas públicas, el análisis documental es una herramienta valiosa para comprender cómo se formalizan las decisiones políticas y cómo se plasman en instrumentos de gestión (Pérez Serrano, 2000),



por lo que resulta una herramienta útil para el recojo y análisis de información vinculante al tema de investigación.

La segunda técnica aplicada es la entrevista semiestructurada, la cual combina preguntas abiertas predefinidas con la posibilidad de repreguntar o adaptar el diálogo a la experiencia del entrevistado. Esta técnica cualitativa es beneciosa para investigaciones donde se busca recoger experiencias porque facilita el acceso a significados, percepciones, motivaciones y valoraciones que los actores construyen sobre su realidad (Taylor y Bogdan, 1990). Además, la entrevista cualitativa es especialmente útil en estudios que requieren comprender relaciones sociales, procesos de decisión o estructuras institucionales desde la perspectiva de los propios actores (Valles, 1997). En síntesis la entrevista permite profundizar en dimensiones subjetivas de fenómenos sociales y acceder a información que no siempre es visible en documentos o estadísticas.

El uso combinado de ambas técnicas en esta investigación resulta pertinente porque permite triangular la información, fortalecer la validez de los hallazgos y captar tanto los marcos institucionales como las experiencias vividas. A través del análisis documental, se recogerá información normativa, programática y presupuestal emitida por el MINSA, la DIRIS Lima Centro y el CSMC “Honorio Delgado” en el periodo 2018-2025, lo que permitirá evaluar el nivel de respaldo institucional hacia el enfoque comunitario. Con las entrevistas semiestructuradas, se obtendrán testimonios de profesionales de salud, miembros del equipo comunitario, lo cual facilitará la reconstrucción de experiencias sobre la implementación del modelo comunitario, las dinámicas participativas y los obstáculos institucionales presentes en el periodo del 2025. De ese modo, la entrevista también permitirá recoger las experiencias y percepciones de los usuarios del CSMC en torno a aspectos clave como su satisfacción con el servicio recibido, la confianza depositada en el centro y en las instituciones públicas que lo respaldan, así como la valoración del centro como un actor que contribuye al bienestar colectivo en su comunidad.

9.5 Población y muestra

Con el fin de responder a las preguntas de esta investigación, se han definido tres unidades de análisis diferenciadas conforme a las categorías conceptuales planteadas: por un lado, la categoría de voluntad política institucional-sectorial será abordada a través de



análisis documental enfocado en entidades del sector salud. Por otro lado, la categoría de implementación de políticas sociales con enfoque comunitario será trabajada mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a profesionales del CSMC “Honorio Delgado”. Y con respecto a la categoría de valor público del CSMC, se recogerá información pertinente mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a usuarios del CSMC “Honorio Delgado”.

En relación con la categoría de voluntad política institucional-sectorial, la técnica de análisis documental se utilizará para identificar y examinar evidencia sobre el nivel de respaldo normativo, presupuestal y operativo brindado por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro al modelo comunitario de atención en salud mental. Por ello, la población documental está conformada por los documentos oficiales emitidos por ambas instituciones en el periodo 2018–2025, los cuales expresan las directrices, estrategias, asignaciones de recursos, planes operativos, acciones de monitoreo y marcos normativos relacionados con la implementación del enfoque comunitario en el ámbito de la salud mental pública, así como el funcionamiento y la expansión de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) a nivel nacional y regional.

De ese modo, la muestra documental será de tipo intencional no probabilística, definida en función de su pertinencia temática y vinculación directa con los indicadores y subcategorías establecidos en la matriz de operacionalización. Esta muestra incluirá, entre los documentos clave: el *Plan Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental Comunitaria* (2018–2021 y actualizaciones), ya que representa el principal marco de planificación estratégica del MINSA respecto al modelo comunitario, y permite analizar los objetivos, metas, fases y criterios técnicos que guían la implementación de los CSMC a nivel nacional; el documento con los lineamientos técnicos para la implementación del modelo comunitario, debido a que establecen las funciones operativas, las orientaciones metodológicas y el rol que deben cumplir tanto los equipos de salud como los gestores institucionales, ofreciendo criterios para evaluar si las acciones del centro se ajustan a lo previsto por el sector; las normativas emitidas por el MINSA respecto a salud mental, como decretos, resoluciones ministeriales y reglamentos técnicos, puesto que son fundamentales para determinar el respaldo legal y programático del modelo comunitario, así como su evolución normativa a lo largo del tiempo.



Asimismo, las directivas operativas de la DIRIS Lima Centro porque permitirán identificar el nivel de articulación entre el centro y los órganos desconcentrados del MINSA, así como los mecanismos de supervisión, apoyo técnico o financiamiento canalizados a través de dicha instancia.

Y como parte de la muestra, también se analizarán los reportes de avance institucional generados por la DIRIS porque contienen información empírica sobre la ejecución de actividades, metas alcanzadas y dificultades operativas, lo cual facilita evaluar el grado de implementación y seguimiento del modelo. Además, los presupuestos asignados al primer nivel de atención en salud mental para analizar el compromiso financiero del sector y la prioridad otorgada a las intervenciones comunitarias; y otra muestra pertinente son los informes de supervisión emitidos hacia los CSMC, como actas de visitas técnicas, informes de monitoreo o evaluaciones internas, las cuales aportarán evidencia directa sobre cómo el sector salud verifica y acompaña el proceso de implementación en los centros comunitarios. Esta documentación, en su conjunto, permitirá evaluar la existencia, continuidad y profundidad del respaldo institucional-sectorial hacia el enfoque comunitario de salud mental, así como identificar si la voluntad política se traduce en acciones concretas de respaldo a la implementación del enfoque comunitario.

Respecto a la categoría de implementación de políticas sociales con enfoque comunitario, la población está compuesta por el personal profesional del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”, especialmente aquellos responsables de ejecutar actividades comunitarias y extramurales. En lo que corresponde a los profesionales del CSMC, para la muestra se empleará un muestreo intencional por bola de nieve debido a las siguientes razones; en primer lugar, obtener información de las personas idóneas para el caso y que sean compatibles con una estrategia intencional; y en segundo lugar, que la muestra poblacional vaya expandiéndose en relación al encuentro con los primeros participantes. De ese modo, la muestra poblacional priorizará a la jefatura del centro, así como a los integrantes del equipo de la Unidad de Movilización y Participación Comunitaria, por su rol estratégico en el diseño e implementación de las acciones comunitarias del modelo. Asimismo, se prevé entrevistar entre 4 y 6 profesionales con experiencia directa en labores comunitarias, priorizando aquellos con conocimientos sobre planificación territorial, articulación con actores locales, y ejecución



de actividades extramurales. El objetivo de esta muestra es comprender, desde la perspectiva operativa e institucional, cómo se implementa el enfoque comunitario, qué estrategias se priorizan, qué mecanismos de participación se promueven, y qué barreras estructurales enfrentan en su ejecución diaria.

En el caso de la categoría de creación de valor público, se toma en consideración como población idónea a los usuarios del centro, es decir, las personas que reciben atención psicológica, psiquiátrica o servicios comunitarios, cuya experiencia es fundamental para valorar la generación de valor público. Para esta categoría de análisis, la delimitación responde a un criterio metodológico de relevancia funcional, ya que las experiencias de este grupo permitirán valorar el grado de participación, apropiación y percepción del servicio como parte de una política con sentido territorial y participativo.

Y en tanto a la muestra, la categorización será de tipo intencional, la muestra también será de tipo intencional, y estará compuesta por personas mayores de edad (entre 20 y 60 años) que hayan recibido atención en el CSMC por un periodo no menor a un mes. La selección buscará diversidad en el tipo de atención recibida (psicológica, psiquiátrica o comunitaria), en el distrito de procedencia (principalmente Pueblo Libre, Jesús María y Breña). Se espera entrevistar a entre 10 y 15 usuarios del centro, cuya participación será completamente voluntaria y anónima. Esta muestra es clave para recoger información sobre la experiencia directa con el servicio, su grado de satisfacción, la confianza depositada en el centro, y su percepción respecto al rol del CSMC como institución promotora del bienestar colectivo. Por ende, este grupo aportará información clave sobre la percepción de valor público generado por el centro.

La decisión de trabajar con ambos grupos responde a un diseño metodológico que busca articular la dimensión institucional con la percepción ciudadana. Así, los profesionales del centro aportan evidencia sobre la implementación técnica y operativa del enfoque comunitario, mientras que los usuarios ofrecen una mirada sobre el impacto real y la pertinencia del servicio desde una perspectiva vivencial. Esta estrategia permitirá obtener una visión integral del proceso de implementación, contrastando las condiciones institucionales con las valoraciones sociales del servicio. De este modo, la selección de la población y muestra se encuentran alineadas con los objetivos de investigación, las técnicas e instrumentos empleados, y la lógica del estudio de caso con enfoque cualitativo.



10. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Fase	Actividad	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Planificación	Planteamiento del problema de investigación	Búsqueda de fuentes, lectura y evaluación de fuentes seleccionadas, descripción de la realidad problemática, plantear preguntas de investigación.	Marzo 2024	Abril 2024
	Elaboración del estado del arte	Revisión bibliográfica, leer y evaluar las fuentes seleccionadas, identificar vacíos en la literatura.	Mayo 2024	Julio 2024
	Elaboración del marco teórico	Búsqueda de fuentes bibliográficas, definición de conceptos clave, revisión de teorías sobre enfoque comunitario y políticas públicas, establecer relaciones entre teorías e integrarlas con el problema de investigación.	Septiembre 2024	Octubre 2024



	Diseño del marco metodológico	Definir el enfoque de investigación, seleccionar el tipo de estudio, determinar la población y muestra, diseñar herramientas para recolección de datos, establecer el procedimiento de recolección de datos	Noviembre 2024	Diciembre 2024
Recolección de datos	Identificar y recopilar la data	Definir criterios de búsqueda, realizar la búsqueda sistemática, organizar y catalogar la data	Febrero 2025	Marzo 2025
	Contactar a los entrevistados	Elaborar un listado de posibles entrevistados, redactar mensajes, correos formales, solicitar cartas de presentación provenientes de la universidad a las entidades de entrevista, confirmar la posibilidad y viabilidad de las entrevistas.	Marzo 2025	Abril 2025
	Diseñar los instrumentos de investigación	Elaborar las preguntas de manera clara y precisa, asegurar la validez y fiabilidad del instrumento, constatar los instrumentos con expertos en el área de investigación.	Abril 2025	Mayo 2025



	Realizar las entrevistas	Preparar el ambiente adecuado, seguir el guión de entrevista, generar confianza con el entrevistado, tomar notas detalladamente o grabar (disposición del entrevistado), brindar un aperitivo de agradecimiento.	Junio 2025	Julio 2025
	Análisis documental	Recopilar seleccionar documentos relevantes, identificar temáticas, mensajes, palabras clave vinculadas y pertinentes para el análisis de la categoría de voluntad política, aplicar herramientas del análisis documental, interpretar los mensajes.	Junio 2025	Julio 2025
Análisis de datos	Organización de los datos	Transcribir las entrevistas, organizar las respuestas por tema o pregunta, codificar las respuestas y clasificar las variables. Recopilar y categorizar los documentos en grupos temáticos .	Agosto 2025	Septiembre 2025
	Codificación y categorización	Clasificar las respuestas en categorías temáticas, agrupar en categorías las respuestas, organizar el contenido de los documentos.	Septiembre 2025	Septiembre 2025
	Interpretación y análisis profundo	Examinar las respuestas en busca de patrones clave o tendencias, comparar las respuestas de los entrevistados, y comparar la información recigida en las entrevistas con la información hallada en los documentos.	Octubre 2025	Octubre 2025



Redacción del trabajo final	Redacción de resultados y discusión	Redacción de los hallazgos del estudio, análisis de su implicancia y comparación con la literatura existente.	Octubre 2025	Octubre 2025
	Elaboración de conclusiones y recomendaciones	Desarrollo de las conclusiones finales y recomendaciones prácticas para la implementación de estrategias futuras.	Noviembre 2025	Noviembre 2025
	Revisión y corrección del documento	Revisión del documento para asegurar la coherencia, precisión y adecuación académica del contenido.	Noviembre 2025	Noviembre 2025
	Preparación del documento final para entrega	Formato final del informe, diseño gráfico y anexos, impresión y encuadernación para presentación.	Noviembre 2025	Diciembre 2025



11. PRESUPUESTO

Tipo	Categoría	Recurso	Descripción	Origen del recurso	Monto
Recursos disponibles	Infraestructura	Equipo	Laptop	Recurso propio	---
		Equipo	Grabadora y cámara digital (celular)	Recurso propio	---
Recursos necesarios	Gastos de trabajo de campo	Fotocopias	Entrega de documentos formales a instituciones (cartas de presentación), entrega del trabajo de investigación, y otros documentos como copia de DNI.	Recursos propios	S/. 100.00
		Transporte	Pasajes para traslados las instituciones públicas y ccentro comunitario, así como otros actores clave para las entrevistas.	Recursos propios	S/. 200.00
		Viáticos	Refrigerio durante los días de trabajo de campo	Recursos propios	S/. 120.00



		Incentivos	Incentivos para entrevistados (regalos simbólicos o refrigerios)	Recursos propios	S/. 150.00
		Otros	Imprevistos (materiales adicionales, permisos, etc.)	Recursos propios	S/. 200.00
	Materiales	Útiles	Bolígrafos, notas adhesivas, marcadores, papelotes, plumones.	Recursos propios	S/. 80.00
		Equipo	Memoria USB para el almacenamiento del trabajo de investigación solicitada por la DIRIS	Recursos propios	S/. 50.00
		Material digital	Suscripción a software de análisis cualitativo	Personal	S/. 200.00
Capacitación	Cursos	Capacitación	Taller sobre implementación de enfoque comunitario en espacios locales	Personal	S/. 150.00
Servicio de terceros	Asesoramiento	Especialista	Transcripción de entrevistas	Personal	S/. 250.00



		Especialista	Corrector de estilo	Personal	S/. 100.00
Total					S/. 1600,00

12. BIBLIOGRAFÍA

- Abazović, D., & Mujkić, A. (2015). Political will: a short introduction. *Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/12465.pdf>
- Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología*. Paidós Educador. <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacer-investigacion-cualitativa.pdf>
- Badillo, I. C., & Corona, B. L. (2021). Desarrollo Municipal y voluntad política: los procesos de transparencia en los municipios hidalguenses. *Revista de ciencias sociales*, (50), 2. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8057172>
- Baena, V. C. (2018). Salud mental comunitaria, atención primaria de salud y universidades promotoras de salud en Ecuador. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e162. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.162>
- Baldeon Miranda, J., Castañeda Molina, B. A., & Silva Tello, R. F. (2022). La falta de diálogo deliberativo como barrera para la implementación del modelo de atención en salud mental comunitaria en la región Callao. <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/1204>
- Bang, C. (2014). Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: Construyendo una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. *Psicoperspectivas*, 13(2). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242014000200011
- Bang, C., & Stolkiner, A. (2013). Participación comunitaria en salud: una revisión crítica desde América Latina. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17162013000100005&script=sci_arttext&tlng=pt
- Canales, M. (2007). El enfoque comunitario: El desafío de incorporar a la comunidad en las intervenciones sociales de Víctor Martínez. *Interamerican Journal of Psychology*, 41(2), 251-253. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S003496902007000200016&script=sci_arttext



- Cano, P. E. T. (2014). *El derecho a la salud mental en el Perú del siglo XXI ¿un derecho protegido o un derecho postergado por el estado peruano?* Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).
<https://www.proquest.com/openview/57625561a605171c28f6f4df92c4c15c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y>
- Castillo-Martell, H., & Cutipé-Cárdenas, Y. (2019). Implementación, resultados iniciales y sostenibilidad de la reforma de servicios de salud mental en el Perú, 2013-2018. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 36, 326-333.
<https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.362.4624>
- Castillo-Martell, H., & Cutipé-Cárdenas, Y. (2019). Implementación, resultados iniciales y sostenibilidad de la reforma de servicios de salud mental en el Perú, 2013-2018. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 36, 326-333.
<https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.362.4624>
- Contreras, S. T., Carmelo, M. A. Q., & Mendívil, R. E. A. (2023). La reforma de salud mental en el Perú, una actualización en el contexto pandémico. *Revista Cuidado y Salud Pública*, 3(2). <https://doi.org/10.53684/csp.v3i2.56>
- De Laubier, S. (1984). Política social y derechos sociales. En Fernández, J., & Caravaca, F. (Eds.), *Política social: Teoría y práctica* (pp. Xx-xx). Editorial.
- Díaz Vásquez, A. C. (2021). Análisis de la implementación de políticas de salud mental en el Perú. El caso de los centros de salud mental comunitarios.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/58795>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
[https://www.deshbandhucollege.ac.in/pdf/e-resources/pol-science/PS\(H\)-IV-Public%20Policy%20and%20Administration%20in%20India-1.pdf](https://www.deshbandhucollege.ac.in/pdf/e-resources/pol-science/PS(H)-IV-Public%20Policy%20and%20Administration%20in%20India-1.pdf)
- Fligler, T. (2022). *El enfoque comunitario en salud mental: estudio de caso Casaclub Baires* (Doctoral dissertation, Universidad de Belgrano-Facultad de Humanidades-Licenciatura en Psicología).
<http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/9824>
- Garretón, M. A. (2001). *Política social y ciudadanía*. Ediciones Universidad Diego Portales.
<https://revistacienciasociales.cl/index.php/publicacion/article/view/69/68>



- Guevara, J., Montes, A., & Olivares, C. (2020). *Metodología de la investigación aplicada a las ciencias sociales*. Fondo Editorial Universidad Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_UC_E_G_MAI_UC0584_2018.pdf
- Hayakawa Córdova, M. (2018). La locura en los valores de la sociedad: explicando el policy change en la formulación de la política de salud mental en el Perú entre 2003 y 2016. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12434>
- Hayakawa, M. (2018). Las coaliciones promotoras de la política pública de salud mental en Perú. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, (10), 55-78. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/175002>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Ingram, H., Schneider, A., & deLeon, P. (2007). Social construction and policy design. In P. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (2nd ed., pp. 93–126). Westview Press. <file:///C:/Users/user/Downloads/sabatier1.pdf>
- Jiménez, F. (2012). *El estudio de caso como metodología de investigación científica en ciencia política*. *Revista de Estudios Políticos*, (157), 193–222. <https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2013). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives* (4th ed.). CQ Press. https://questanbridge.com/wp-content/uploads/2024/11/Public-policy_-politics-analysis-and-alternatives.pdf
- Leiva-Peña, V., Rubí-González, P., & Vicente-Parada, B. (2021). Determinantes sociales de la salud mental: políticas públicas desde el modelo biopsicosocial en países latinoamericanos. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 45. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55365>
- Lopera, J. D. (2014). El concepto de salud mental en algunos instrumentos de políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 32, S11-S20. <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.19792>



- Madrid, J. C. C. (2019). “Locos por nuestros derechos”: Comunidad, salud mental y ciudadanía en el Chile contemporáneo. *Quaderns de Psicologia*, 21(2), e1502-e1502. <https://quadernsdepsicologia.cat/article/view/v21-n2-Cea>
- Martínez Ravanal, V. M. (2006). El enfoque comunitario. Estudio de sus modelos de base. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17162013000100005&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17162013000100005&script=sci_arttext&tlng=pt
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122235/martinezravanal_elenfoque-comunitario.pdf?sequence=1
- Minoletti, A., & Zaccaria, C. (2005). Modelo comunitario en salud mental: Avances y desafíos. *Revista Chilena de Salud Pública*, 9(3), 213-220. <https://www.scielo.org/pdf/rpsp/v18n4-5/28097.pdf>
- Minoletti, A., Sepúlveda, R., Gómez, M., Toro, O., Irrázabal, M., Díaz, R., & Chacón, S. (2018). Análisis de la gobernanza en la implementación del modelo comunitario de salud mental en Chile. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42, e131. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.131>
- Organización Mundial de la Salud y UNICEF. (1978). Declaración de Alma-Ata. OMS. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/39244/9243541358.pdf>
- Pérez Serrano, G. (2000). *Investigación cualitativa: Retos e interrogantes* (Vol. I). La Muralla. https://concreactraul.weebly.com/uploads/2/2/9/5/22958232/investigacin_cualitativa.pdf
- Pisfil, M. (2006). Políticas públicas en el Perú: Retos y perspectivas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/504>
- Post, L. A., Raile, A. N., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics & Policy*, 38(4), 653-676. <https://scholarworks.montana.edu/server/api/core/bitstreams/b44a24eb-0353-4dfa-8985-7319b6515fb0/content>



- Rodas, S. T., Sánchez, S. M. F. C., Calderón, H. M. V., & Pardo, M. S. C. (2022). Revisión epidemiológica de los trastornos mentales en el Perú. *PsiqueMag*, 11(1), 98-108. <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v11i1.2655>
- Rosa-Dávila, E., & Mercado-Sierra, M. A. (2020). Salud Mental Comunitaria: Una Explicación del Modelo. *Voces desde el Trabajo Social*, 272-290. <https://orcid.org/0000-0003-1831-1299>
- Rosa-Dávila, E., & Mercado-Sierra, M. A. (2020). Salud mental comunitaria: Una explicación del modelo. *Voces Desde El Trabajo Social*, 8(1), 272-290. <https://revistavocests.org/index.php/voces/article/view/227>
- Rosa-Dávila, E., & Mercado-Sierra, M. A. (2020). Salud Mental Comunitaria: Una Explicación del Modelo. *Voces desde el Trabajo Social*, 272-290. <https://www.revistavocests.org/index.php/voces/article/view/227>
- Rubio, J. (2012). *Diseños de investigación en ciencia política*. Editorial UOC. <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/metodologia-de-la-investigacion.pdf>
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2014). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill. <https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>
- Satizabal-Reyes, M., & Ortiz-Quiroga, D. (2020). Mentalmente Sanos: Una experiencia con enfoque comunitario. *Revista de Salud Pública*, 21. <https://doi.org/10.15446/rsap.V21n1.63309>
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1990). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Paidós. <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- Valles, M. S. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis. <https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/12de20/Valles%20-%20Investigacionj%20cualitativa.pdf>



- Vega Neira, C. A. (2023). Implementación del modelo de salud mental comunitaria en la reconversión de un policlínico de psiquiatría hospitalario hacia un centro de salud mental comunitaria. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/198799>
- Velázquez, T., & Seminario, E. (2017). Implementación comunitaria de políticas de salud mental en Perú: Avances y desafíos. *Revista Peruana de Salud Pública*, 31(2), 150-160. <https://cris.pucp.edu.pe/es/publications/between-remembering-and-forgetting-the-years-of-political-violenc-2>
- Vitelleschi, M. B., & Muñoz, O. (2023). Políticas públicas y salud mental comunitaria: Un análisis desde la experiencia regional. *Revista Latinoamericana de Salud Mental*, 45(1), 45-60. <https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/6692>
- Yin, R. K. (2003). *Estudio de caso: Diseño y métodos*. Sage Publications. <https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/YIN%20ROBERT%20.pdf>
- Zegarra, W., Olano, D., Lluncor, M., & Cacho, A. (2021). El valor público, característica fundamental en la nueva gestión pública Public value, a fundamental characteristic in the new public management. *Revista Pakamuros*, 9(1), 21-30. <https://revistas.unj.edu.pe/index.php/pakamuros/article/view/124>



13. ANEXOS

a. Matriz de consistencia

Análisis de la implementación del enfoque comunitario de salud mental (2018 - 2025): Estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre

Preguntas	Objetivos	Categorías	Hipótesis	Metodología
Pregunta general ¿En qué medida los factores político-institucionales asociados al enfoque comunitario de salud mental inciden en la implementación del enfoque comunitario y en la satisfacción de los usuarios en el Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre durante el periodo 2018–2025??	Objetivo general Analizar el impacto de la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre en la satisfacción de los servicios brindados por el CSMC de Pueblo Libre en el periodo 2018–2025.	Enfoque comunitario de salud mental	La calidad de la implementación del enfoque comunitario en el Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” está condicionada por un conjunto de factores político - institucionales como la voluntad política y la implementación adecuada de la política social . En ese sentido, la consolidación del enfoque comunitario requiere de factores políticos e institucionales consistentes, cuya presencia , o ausencia, tiene un impacto directo en la capacidad del centro para generar intervenciones pertinentes y lograr la satisfacción de los usuarios con el servicio recibido.	Enfoque Mixto Alcance Descriptivo y exploratorio Diseño Estudio de caso Población



Pregunta específico 1 ¿De qué manera la voluntad política institucional-sectorial influye en el proceso de implementación del enfoque comunitario en el CSMC de Pueblo Libre en el periodo 2018-2025?	Objetivo específico 1 Comprender cómo la voluntad política institucional-sectorial del MINSA y la DIRIS se expresa en acciones concretas de respaldo técnico, normativo y operativo que influyen en la implementación del enfoque comunitario en el CSMC de Pueblo Libre durante el periodo 2018-2025.	Voluntad política institucional - sectorial	La voluntad política institucional-sectorial del Ministerio de Salud y de la DIRIS Lima Centro ha tenido un rol determinante en la implementación del enfoque comunitario en el CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre durante el periodo 2018–2025. Este respaldo político se manifiesta en la formulación de lineamientos técnicos, asignación de recursos humanos y financieros, y mecanismos de acompañamiento institucional. La existencia, o ausencia, sostenida de estas acciones ha condicionado la capacidad del centro para desarrollar intervenciones comunitarias pertinentes y sostenidas, afectando directamente la profundidad y calidad con que se implementa el modelo de atención comunitaria.	Documentos técnicos, funcionarios públicos, profesionales y usuarios. Muestra De bola de nieve Personal de la Unidad de Movilización Comunitaria del CSMC “Honorio Delgado” / Usuarios del servicio del CSMC.
--	---	--	---	--



Pregunta específico 2 ¿De qué manera se implementa el enfoque comunitario de la política social de salud mental por parte del equipo del CSMC “Honorio Delgado”?	Objetivo específico 2 Analizar la implementación del enfoque comunitario de la política social de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado', identificando las estrategias, mecanismos de participación y factores que dificultan su aplicación desde la perspectiva del equipo profesional.	Implementación de política social con enfoque comunitario	Se presume que la manera en que el equipo profesional del Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado' implementa las estrategias y mecanismos de participación comunitaria, así como los factores que condicionan dicha implementación, como los recursos disponibles o las dinámicas institucionales, inciden en los resultados y alcances efectivos de la política social de salud mental con enfoque comunitario.	Técnica Entrevista Análisis documental Instrumento Guía de entrevista Cuadro de registro
Pregunta específico 3 ¿Cuáles han sido los efectos de la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre a nivel de percepción y satisfacción en la cadena de valor público del servicio ofrecido?	Objetivo específico 3 Determinar los efectos de la implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Pueblo Libre en relación a la creación de satisfacción y percepción en la cadena de valor público del servicio del centro.	Valor público a nivel de satisfacción del usuario	La implementación efectiva del CSMC de Pueblo Libre contribuye a la generación de valor público, reflejado en una mayor satisfacción de los usuarios, fortalecimiento de la confianza institucional y mejoras en el bienestar colectivo, este impacto real y socialmente percibido del CSMC no se mide solo por cobertura o atención clínica, sino por su capacidad de producir bienes públicos valorados por la comunidad.	



b. Matriz de operacionalización de variables

Objetivos	Categorías	Definición conceptual	Subcategoría	Definición conceptual	Indicadores	Preguntas / Ítems	Instrumento	Población / muestra
Objetivo específico 1 Analizar el impacto de la implementación del enfoque comunitario de salud mental en el CSMC “Honorio Delgado” de Pueblo Libre en la satisfacción de los servicios brindados por el CSMC de Pueblo Libre en el periodo 2018–2025.	Categoría 1 Voluntad política institucional sectorial en la implementación de servicios de salud mental comunitaria	Comprende el fenómeno de cómo las instituciones superiores (MINSA y DIRIS) no solo declaran su apoyo al modelo comunitario, sino también acerca de qué acciones concretas realizan para impulsar su implementación y verificar que se esté llevando a cabo	Compromiso normativo y programático	Se refiere al grado en que las instituciones del sector salud, principalmente el MINSA y la DIRIS, han desarrollado y formalizado normativas, lineamientos, planes estratégicos y operativos que incorporan y respaldan el modelo comunitario de atención en salud mental, garantizando que sea una	Existencia de lineamientos normativos y documentos técnicos que respalden el enfoque comunitario	¿Cuáles son los principales documentos normativos que sustentan el modelo comunitario de salud mental en su institución?	Análisis documental	
					Inclusión del modelo comunitario en planes estratégicos y operativos del	¿Cómo se han difundido estos lineamientos entre el personal técnico y administrativo?		
						¿De qué manera está incorporado el enfoque comunitario en los planes estratégicos y operativos anuales?	Análisis documental	



		adecuadamente.		prioridad en la agenda sectorial y que cuente con directrices claras para su ejecución.	MINSA y DIRIS	¿Existen metas o indicadores específicos relacionados con la implementación del modelo comunitario en estos planes?		
					Actualización periódica de políticas públicas en salud mental con enfoque comunitario	¿Con qué frecuencia se revisan o actualizan las políticas y normativas relacionadas con la salud mental comunitaria?	Análisis documental	
						¿Qué mecanismos se utilizan para evaluar la pertinencia y eficacia de estas políticas?		



			Sostenibilidad y respaldo institucional	Comprende la capacidad de las instituciones para asegurar la continuidad y fortalecimiento del modelo comunitario a través de la asignación adecuada de recursos materiales, humanos y financieros. El respaldo institucional también implica un compromiso con la asignación presupuestal que garantice la operatividad	Asignación presupuestal específica para actividades comunitarias en salud mental	¿Existe una asignación presupuestal diferenciada para actividades comunitarias dentro de la salud mental?	Análisis documental	
						¿Cómo se distribuyen los recursos entre atención clínica y actividades comunitarias?		
						¿Han existido cambios significativos en el presupuesto destinado a estas actividades en los últimos años?		



				sostenible del enfoque comunitario.	Estabilidad y permanencia del personal dedicado a actividades extramurales	¿Qué estrategias se emplean para garantizar la estabilidad del personal que realiza trabajo comunitario?	Análisis documental	
						¿El equipo cuenta con contratos estables y formación continua para mantener sus funciones?		
					Disponibilidad de programas de capacitación para el enfoque comunitario en salud mental	¿Qué tipo de capacitaciones se ofrecen al personal para fortalecer el enfoque comunitario?	Análisis documental	
						¿Con qué frecuencia se realizan estas capacitaciones y quiénes participan?		



			Impulso institucional y mecanismos de seguimiento	Refleja el nivel de compromiso activo y dinámico de las instituciones para impulsar la implementación efectiva del enfoque comunitario en salud mental. Asimismo, comprende las acciones concretas que las entidades rectoras del sector salud implementan para promover, supervisar y acompañar la puesta en marcha del modelo	Existencia de acciones de monitoreo o supervisión por parte de la DIRIS o MINSA sobre la implementación del enfoque comunitario	¿Qué tipo de monitoreo o supervisión se realiza sobre la implementación del modelo comunitario en los CSMC? ¿Con qué periodicidad se llevan a cabo estas actividades? ¿Qué tipo de dificultades o limitaciones han encontrado para llevar a cabo las acciones de monitoreo? ¿Considera que hay voluntad política para superarlas?	Análisis documental	
--	--	--	---	---	---	--	---------------------	--



				comunitario en los Centros de Salud Mental Comunitarios.	Disponibilidad de acompañamiento o técnico y asesoría institucional para fortalecer el enfoque comunitario	¿De qué manera las instancias superiores brindan acompañamiento o técnico al personal del CSMC?	Análisis documental	
						¿Se ofrecen asesorías o apoyo metodológico específicos para actividades comunitarias?		
					Reconocimiento institucional a iniciativas exitosas de intervención comunitaria	¿Qué tipo de mecanismos existen para reconocer o premiar las buenas prácticas en el trabajo comunitario?	Análisis documental	
						¿Se difunden experiencias exitosas para motivar a otros equipos o centros? ¿A		



						través de qué canales de difusión?		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Objetivo específico 2 Analizar la implementación del enfoque comunitario en la política social de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado', identificando las estrategias, mecanismos de participación y factores que dificultan su aplicación	Categoría 2 Implementación de política social con enfoque comunitario	El conjunto de acciones, estrategias y prácticas que desarrollan los equipos profesionales encargados de ejecutar una política pública diseñada para actuar desde, con y para la comunidad. En el caso del CSMC "Honorio Delgado", esta implementación se concreta en actividades psicosociales, campañas, articulación	Estrategias de intervención comunitaria	Comprenden el conjunto de acciones y metodologías aplicadas por los profesionales del centro de salud mental con el fin de llevar los servicios más allá del ámbito clínico individual hacia el espacio colectivo y territorial. Estas estrategias incluyen actividades psicoeducativas, campañas, visitas	Presencia de actividades comunitarias organizadas	¿Qué tipo de actividades comunitarias desarrolla el centro?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Con qué frecuencia se realizan estas actividades y quiénes participan?		
						¿Qué criterios utilizan para decidir en qué espacios o comunidades intervenir?		
					Rol del equipo de movilización comunitaria	¿Cuál es el rol específico del equipo de	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesional



desde la perspectiva del equipo profesional.		territorial y participación de usuarios y familias, dentro del marco de la política nacional de salud mental impulsada por el MINSA.		domiciliarias, talleres, ferias comunitarias y otras formas de interacción directa con la comunidad.		movilización dentro del CSMC?		es miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Cómo se organizan las funciones del equipo comunitario en relación con el resto del centro?		
						¿Qué logros consideran que ha tenido el equipo comunitario en el territorio?		
					Incorporación del enfoque territorial en las intervenciones	¿Cómo consideran el contexto social del distrito para planificar sus intervenciones?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación
						¿Qué estrategias usan para adaptar sus acciones a las		



						necesidades específicas de la comunidad? ¿Qué tan articulado está su trabajo con otros espacios comunitarios del distrito?		comunitaria
			Participación y corresponsabilidad	Comprende el análisis del nivel de participación de la ciudadanía y los profesionales del centro en la toma de decisiones y ejecución de actividades del CSMC, por lo que con esta dimensión es posible analizar si hay	Participación de usuarios en espacios comunitarios	¿Qué tipos de espacios de participación ciudadana activa existen dentro del CSMC (campañas, actividades deportivas, talleres artísticos)? ¿Qué rol o de qué forma los usuarios participan en actividades que no son estrictamente clínicas?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria



				participación efectiva.		En su experiencia, ¿De qué manera estos espacios de participación activa impactan en los resultados del centro?		
					Estrategias para fomentar corresponsabilidad familiar	¿Cómo involucran a las familias en los procesos de atención de los usuarios?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Existen espacios específicos para el trabajo con familias?		
						¿Qué tan receptiva es la familia frente a estas estrategias de corresponsabilidad?		



					Canales de retroalimentación y diálogo con la comunidad	¿Cuentan con espacios o mecanismos donde la comunidad pueda expresar sus opiniones sobre el centro?	Entrevista semiestructurada.	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Qué hacen con los comentarios o sugerencias que reciben de usuarios o vecinos?		
						¿Se han tomado decisiones o adaptado servicios a partir de estos aportes comunitarios?		



				Factores que dificultan la implementación	Se refiere a los obstáculos de tipo institucional, operativo o contextual que limitan la puesta en práctica efectiva del enfoque comunitario de salud mental. Asimismo, identificar estos factores permite comprender las brechas entre el diseño de la política y su aplicación real en el territorio. .	Limitaciones institucionales (logística, recursos)	¿Qué dificultades institucionales enfrentan para llevar a cabo el enfoque comunitario?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales es miembros de la unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Con qué recursos cuentan actualmente para actividades fuera del centro?			
						¿Cómo afecta la falta de materiales, transporte o personal a las intervenciones comunitarias?			
						Carga laboral del personal	¿El equipo cuenta con suficiente tiempo para realizar actividades comunitarias?	Entrevista Semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales es miembros de la



						¿Cómo se equilibran las funciones clínicas con las tareas de movilización comunitaria?		unidad de movilización y participación comunitaria
						¿Sienten que la carga laboral limita el desarrollo del enfoque comunitario?		
					Articulación con otros actores locales	¿Qué tan fácil o difícil es coordinar con otras instituciones del distrito (escuelas, municipios, ONGs)?	Entrevista semiestructurada	Gerencia del CSMC/ profesionales miembros de la unidad de movilización y participación
						¿Existen experiencias de articulación interinstitucional? ¿Qué resultados tuvieron?		



						¿Qué obstáculos encuentran para construir redes de trabajo en la comunidad?		comunitaria
--	--	--	--	--	--	---	--	-------------

Objetivo específico 3 Determinar los efectos de la implementación del enfoque comunitario en relación a la	Categoría 3 Valor público del CSMC	Es el resultado tangible e intangible de una política, programa o servicio público que	Satisfacción y percepción de la ciudadanía	Es el nivel de conformidad y valoración que expresan los usuarios y miembros de la comunidad respecto a la	Nivel de satisfacción con los servicios recibidos	¿Cómo ha sido su experiencia recibiendo atención en el Centro de Salud Mental Comunitario?	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades
						¿Qué es lo que más valora de los servicios		



creación de valor público dentro del CSMC de Pueblo Libre.		responde a las necesidades, intereses y expectativas de la ciudadanía, generando beneficios colectivos, fortaleciendo o la legitimidad institucional y mejorando el bienestar social. Este valor público se produce cuando el Estado actúa con efectividad, legitimidad y eficiencia, de modo que logra crear resultados que son	calidad, pertinencia y accesibilidad del servicio público recibido, así como a la forma en que experimentan la atención y el trato por parte de la institución. Permite captar no solo la eficacia operativa del servicio, sino también la experiencia subjetiva del ciudadano, que es clave en la generación de valor público.		brindados por el CSMC?	que oscilan de los 20 a los 60 años.
					¿Qué aspecto del servicio considera que debería mejorar para que sea más útil o efectivo para usted y su comunidad?	
				Accesibilidad y adecuación del servicio a las necesidades locales	¿Considera que los horarios, la ubicación se ajustan a sus necesidades y a las de otras personas de su comunidad? ¿Cómo?	
					¿Considera que los servicios del centro se ajustan a sus necesidades y a las de otras personas de su comunidad? ¿De qué manera?	
				Entrevista semiestructurada		



		valorados por la sociedad y que refuerzan el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.				¿Ha tenido dificultades para acceder a los servicios del centro (por ejemplo, tiempo de espera, transporte, disponibilidad de citas)? ¿Cómo lo resolvió?		
					Trato digno y respeto a los usuarios	¿Cómo se ha sentido tratado(a) por el personal del centro?	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.
						¿Cómo percibe el trato que recibe por parte del personal del centro en cuanto a ser escuchado(a) y tomado(a) en cuenta?		



						¿De qué manera ha sentido que su cultura o su situación personal son tomadas en cuenta en su atención dentro del centro?		
			Legitimidad y confianza institucional	Es el grado en que la ciudadanía percibe que una institución pública actúa de manera justa, transparente, competente y en beneficio del interés colectivo, lo que fortalece su aceptación y respaldo social. No solo es vinculante	Reconocimiento del CSMC como actor importante en el distrito	¿Podría compartir su opinión o alguna experiencia que le haya mostrado la importancia del centro para su distrito? Considerando la movilización del centro a espacios como los colegios, etc ¿De qué manera cree que otras personas en su distrito conocen el	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.



				con la legalidad formal de la institución, sino la percepción de que su actuación es adecuada y digna de confianza, lo cual es fundamental para sostener el valor público a largo plazo		trabajo que hace el centro?		
					Nivel de confianza hacia el centro y su personal	¿Podría contar si el trabajo que realiza el centro le genera confianza?	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.
						¿Se siente cómodo(a) al acudir o recomendarlo a otras personas afines? ¿Cómo llegó a esa conclusión?		
						¿En qué momento sintió que podía confiar en el personal del centro? ¿Hubo algo que le generó confianza o		



						desconfianza inicialmente?		
					Identificación de alianzas o colaboración con actores locales	¿Conoce si el centro trabaja en conjunto con otras instituciones del distrito, como la municipalidad, colegios u organizaciones vecinales? Mencione qué actividades en colaboración conoce que se realicen.	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.
						¿Le parece importante que el centro comunitario trabaje en conjunto con la municipalidad u otras instituciones? ¿De qué manera cree		



				que esto sería útil o no?		
Contribución al bienestar colectivo	Es el impacto positivo que un servicio o política pública genera en la calidad de vida de la comunidad, abordando problemáticas sociales relevantes y promoviendo entornos más saludables, seguros y equitativos. Evalúa cómo el servicio público, en este caso el CSMC, trasciende la atención individual para producir	Percepción de mejoras en la salud mental de la comunidad	¿Cómo cree que la existencia del centro ha influido en la salud mental de su comunidad o de su familia?	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.	
			¿Puede darme un ejemplo concreto de algún cambio positivo en su entorno familiar o comunitario?			
		Impacto en la reducción del estigma hacia la salud mental	¿Considera que en los últimos años ha cambiado la forma en que se habla o se ve la salud mental en el distrito?	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos	



				beneficios sostenibles y compartidos a nivel comunitario		¿Cree que el centro ha tenido algo que ver en ese cambio? ¿Podría explicar de qué manera cree que se relaciona el centro comunitario en ese cambio?		diagnósticos y edades que oscilan de los 20 a los 60 años.
						¿Antes de acudir al centro, qué pensaba usted (o su entorno) sobre la salud mental, y qué percepción tiene ahora?		
					Participación en actividades de fortalecimiento comunitario	¿Ha participado usted o alguien que conoce en actividades comunitarias organizadas por el centro, como talleres, ferias o	Entrevista semiestructurada	Usuarios pacientes del CSMC / seis usuarios con diversos diagnósticos y edades



						campañas? Cuenta su experiencia.		que oscilan de los 20 a los 60 años.
						¿Cuál es su percepción de dichas actividades comunitarias?		
						¿Considera que esas actividades organizadas por el centro fortalecen la unión y participación en su comunidad? ¿Por qué sí o por qué no?		

INSTRUMENTOS

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Título del estudio: Análisis de la implementación del enfoque comunitario de salud mental (2018 y 2025): Estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre.

1. Objetivo de análisis documental

El objetivo del análisis documental es identificar y examinar las normas, planes, informes, presupuestos y otros documentos oficiales que regulan, respaldan o condicionan la implementación del enfoque comunitario en salud mental desde el Ministerio de Salud (MINSA), la DIRIS Lima Centro y el propio CSMC “Honorio Delgado”, en el periodo 2018–2025.

2. Categoría por analizar: Voluntad política institucional-sectorial

a. Subcategoría: Compromiso normativo y programático

Indicador: Existencia de lineamientos normativos y documentos técnicos que respalden el enfoque comunitario

- ¿Cuáles son los principales documentos normativos que sustentan el modelo comunitario de salud mental en su institución?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Cómo se han difundido estos lineamientos entre el personal técnico y administrativo?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	



Indicador: Inclusión del modelo comunitario en planes estratégicos y operativos del MINSA y DIRIS

- ¿De qué manera está incorporado el enfoque comunitario en los planes estratégicos y operativos anuales?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Existen metas o indicadores específicos relacionados con la implementación del modelo comunitario en estos planes?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

Indicador: Actualización periódica de políticas públicas en salud mental con enfoque comunitario

- ¿Con qué frecuencia se revisan o actualizan las políticas y normativas relacionadas con la salud mental comunitaria?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Qué mecanismos se utilizan para evaluar la pertinencia y eficacia de estas políticas?



Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

b. Subcategoría: Sostenibilidad y respaldo institucional

Indicador: Asignación presupuestal específica para actividades comunitarias

- ¿Existe una asignación presupuestal diferenciada para actividades comunitarias dentro de la salud mental?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Cómo se distribuyen los recursos entre atención clínica y actividades comunitarias?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Han existido cambios significativos en el presupuesto destinado a estas actividades en los últimos años?

Tipo de documento	
Título	
Autor	



Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

Indicador: Estabilidad y permanencia del personal dedicado a actividades extramurales

- ¿Qué estrategias se emplean para garantizar la estabilidad del personal que realiza trabajo comunitario?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿El equipo cuenta con contratos estables y formación continua para mantener sus funciones?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

Indicador: Disponibilidad de programas de capacitación para el enfoque comunitario

- ¿Qué tipo de capacitaciones se ofrecen al personal para fortalecer el enfoque comunitario?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	



Enlace	
Fragmento	

- ¿Con qué frecuencia se realizan estas capacitaciones y quiénes participan?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

c. Subcategoría: Impulso institucional y mecanismos de seguimiento

Indicador: Existencia de acciones de monitoreo o supervisión por parte de la DIRIS o MINSA

- ¿Qué tipo de monitoreo o supervisión se realiza sobre la implementación del modelo comunitario en los CSMC?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Con qué periodicidad se llevan a cabo estas actividades?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Qué tipo de dificultades han encontrado para realizar estas acciones?



Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

Indicador: Disponibilidad de acompañamiento técnico y asesoría institucional

- ¿De qué manera las instancias superiores brindan acompañamiento técnico al personal del CSMC?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Se ofrecen asesorías o apoyo metodológico específicos para actividades comunitarias?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

Indicador: Reconocimiento institucional a iniciativas exitosas

- ¿Qué mecanismos existen para reconocer o premiar las buenas prácticas en el trabajo comunitario?

Tipo de documento	
Título	
Autor	



Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

- ¿Se difunden experiencias exitosas para motivar a otros equipos o centros? ¿A través de qué canales?

Tipo de documento	
Título	
Autor	
Año de publicación	
Fuente	
Enlace	
Fragmento	

**GUÍA DE ENTREVISTA A LA JEFATURA Y LA UNIDAD DE
MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL CSMC
“HONORIO DELGADO”**

1. Presentación personal y pautas éticas

Buenos días/tardes. Mi nombre es Nayeli Castillo Montalvo y soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy realizando una investigación para mi tesis titulada: Análisis de la implementación del enfoque comunitario de salud mental (2018 y 2025): Estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre.

El objetivo de esta entrevista es recolectar información cualitativa sobre la implementación del enfoque comunitario de la política social de salud mental en el Centro de Salud Mental Comunitario 'Honorio Delgado', identificando las estrategias, mecanismos de participación y factores que dificultan su aplicación desde la perspectiva del equipo profesional. De modo que su participación es importante para obtener su opinión y experiencia respecto a cómo se gestiona el centro comunitario, especialmente en cuanto a las siguientes subcategorías, estrategias de intervención comunitaria, participación y corresponsabilidad y factores que limitan la implementación del enfoque; las cuales responden a mi categoría principal denominada: implementación de política social con enfoque comunitario. La información que usted comparta será tratada con total confidencialidad, será usada únicamente con fines académicos, y en ningún momento se publicará su nombre o cargo sin consentimiento previo.

2. Datos generales del entrevistado

Nombre completo:

Cargo dentro del CSMC:



La entrevista tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos, siendo la población objetivo, la Gerencia del CSMC y los profesionales de la Unidad de Movilización y Participación Comunitaria

3. Preguntas

Categoría 2: Implementación de política social con enfoque comunitario

Subcategoría 1: Estrategias de intervención comunitaria

Con respecto a la **presencia de actividades comunitarias organizadas:**

- ¿Qué tipo de actividades comunitarias desarrolla el centro?
- ¿Con qué frecuencia se realizan estas actividades y quiénes participan?
- ¿Qué criterios utilizan para decidir en qué espacios o comunidades intervenir?

Con respecto al **rol del equipo de movilización comunitaria:**

- ¿Cuál es el rol específico del equipo de movilización dentro del CSMC?
- ¿Cómo se organizan las funciones del equipo comunitario en relación con el resto del centro?
- ¿Qué logros consideran que ha tenido el equipo comunitario en el territorio?

Con respecto a la **incorporación del enfoque territorial en las intervenciones:**

- ¿Cómo consideran el contexto social del distrito para planificar sus intervenciones?
- ¿Qué estrategias usan para adaptar sus acciones a las necesidades específicas de la comunidad?
- ¿Qué tan articulado está su trabajo con otros espacios comunitarios del distrito?

Subcategoría 2: Participación y corresponsabilidad

Con respecto a la **participación de usuarios en espacios comunitarios:**

- ¿Qué tipos de espacios de participación ciudadana activa existen dentro del CSMC (campañas, actividades deportivas, talleres artísticos)?
- ¿Qué rol o de qué forma los usuarios participan en actividades que no son estrictamente clínicas?
- En su experiencia, ¿De qué manera estos espacios de participación activa impactan en los resultados del centro?

Con respecto a las **estrategias para fomentar corresponsabilidad familiar:**



- ¿Cómo involucran a las familias en los procesos de atención de los usuarios?
- ¿Existen espacios específicos para el trabajo con familias?
- ¿Qué tan receptiva es la familia frente a estas estrategias de corresponsabilidad?

Con respecto a los **canales de retroalimentación y diálogo con la comunidad:**

- ¿Cuentan con espacios o mecanismos donde la comunidad pueda expresar sus opiniones sobre el centro?
- ¿Qué hacen con los comentarios o sugerencias que reciben de usuarios o vecinos?
- ¿Se han tomado decisiones o adaptado servicios a partir de estos aportes comunitarios?

Subcategoría 3: Factores que dificultan la implementación

Con respecto a **limitaciones institucionales (logística, recursos):**

- ¿Qué dificultades institucionales enfrentan para llevar a cabo el enfoque comunitario?
- ¿Con qué recursos cuentan actualmente para actividades fuera del centro?
- ¿Cómo afecta la falta de materiales, transporte o personal a las intervenciones comunitarias?

Con respecto a la **carga laboral del personal:**

- ¿El equipo cuenta con suficiente tiempo para realizar actividades comunitarias?
- ¿Cómo se equilibran las funciones clínicas con las tareas de movilización comunitaria?
- ¿Sienten que la carga laboral limita el desarrollo del enfoque comunitario?

Con respecto a la **articulación con otros actores locales:**

- ¿Qué tan fácil o difícil es coordinar con otras instituciones del distrito (escuelas, municipios, ONGs)?
- ¿Existen experiencias de articulación interinstitucional? ¿Qué resultados tuvieron?
- ¿Qué obstáculos encuentran para construir redes de trabajo en la comunidad?

Notas para la entrevistadora:

- Permitir que el entrevistado se exprese con libertad.



- Pedir ejemplos o experiencias concretas siempre que sea posible.
- Si surge un tema emergente relevante, puedes explorarlo aunque no esté en la guía.
- Registrar respuestas completas y grabar con consentimiento.

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS USUARIOS DEL CSMC “HONORIO DELGADO”

1. Presentación personal y pautas éticas

Buenos días/tardes. Mi nombre es Nayeli Castillo Montalvo y soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy realizando una investigación para mi tesis titulada: Análisis de la implementación del enfoque comunitario de salud mental (2018 y 2025): Estudio de caso del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” en Pueblo Libre.

El objetivo de esta entrevista es recolectar información cualitativa sobre la percepción de los usuarios del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado” respecto al valor público generado por los servicios que reciben. De modo que su participación es importante para obtener su opinión y experiencia respecto al valor que el centro comunitario genera en su vida y en la vida comunitaria vecinal, especialmente en cuanto a las siguientes subcategorías, en función de su nivel de satisfacción, la confianza institucional y la contribución en el bienestar colectivo; las cuales responden a mi categoría principal denominada valor público del CSMC. La información que usted comparta será tratada con total confidencialidad, será usada únicamente con fines académicos, y en ningún momento se publicará su nombre o cargo sin consentimiento previo.

1. Datos generales del entrevistado

Nombre completo:

Sexo / edad:

Tiempo recibiendo atención en el centro:

Diagnóstico general (si es voluntariamente compartido):

Frecuencia de visitas:

La entrevista tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos, siendo la población objetivo, los usuarios del Centro de Salud Mental Comunitario “Honorio Delgado”.

2. Preguntas

Categoría 3: Valor público del CSMC

Subcategoría 1: Satisfacción y percepción de la ciudadanía

Con respecto **al nivel de satisfacción con los servicios recibidos:**



- ¿Cómo ha sido su experiencia recibiendo atención en el Centro de Salud Mental Comunitario?
- ¿Qué es lo que más valora de los servicios brindados por el CSMC?
- ¿Qué aspecto del servicio considera que debería mejorar para que sea más útil o efectivo para usted y su comunidad?

Con respecto a la **accesibilidad y adecuación del servicio a las necesidades locales:**

- ¿Considera que los horarios, la ubicación se ajustan a sus necesidades y a las de otras personas de su comunidad?
- ¿Considera que los servicios del centro se ajustan a sus necesidades y a las de otras personas de su comunidad? ¿De qué manera?
- ¿Ha tenido dificultades para acceder a los servicios del centro (por ejemplo, tiempo de espera, transporte, disponibilidad de citas)? ¿Cómo lo resolvió?

Con respecto al **trato digno y respeto a los usuarios:**

- ¿Cómo se ha sentido tratado(a) por el personal del centro?
- ¿Cómo percibe el trato que recibe por parte del personal del centro en cuanto a ser escuchado(a) y tomado(a) en cuenta?
- ¿De qué manera ha sentido que su cultura o su situación personal son tomadas en cuenta en su atención dentro del centro?

Subcategoría 2: Legitimidad y confianza institucional

Con respecto al **reconocimiento del CSMC como actor importante en el distrito:**

- ¿Podría compartir su opinión o alguna experiencia que le haya mostrado la importancia del centro para su distrito?
- Considerando la movilización del centro a espacios como los colegios, etc ¿De qué manera cree que otras personas en su distrito conocen el trabajo que hace el centro?

Con respecto al **nivel de confianza hacia el centro y su personal:**

- ¿Podría contar si el trabajo que realiza el centro le genera confianza?
- ¿Se siente cómodo(a) al acudir o recomendarlo a otras personas afines? ¿Cómo llegó a esa conclusión?
- ¿En qué momento sintió que podía confiar en el personal del centro? ¿Hubo algo que le generó confianza o desconfianza inicialmente?

Con respecto a la **identificación de alianzas o colaboración con actores locales:**

- ¿Conoce si el centro trabaja en conjunto con otras instituciones del distrito, como la municipalidad, colegios u organizaciones vecinales? Mencione qué actividades en colaboración conoce que se realicen.
- ¿Le parece importante que el centro comunitario trabaje en conjunto con la municipalidad u otras instituciones? ¿De qué manera cree que esto sería útil o no?

Subcategoría 3: Contribución al bienestar colectivo



Con respecto a la **percepción de mejoras en la salud mental de la comunidad:**

- ¿Cómo cree que la existencia del centro ha influido en la salud mental de su comunidad o de su familia?
- ¿Puede darme un ejemplo concreto de algún cambio positivo en su entorno familiar o comunitario?

Con respecto al **impacto en la reducción del estigma hacia la salud mental:**

- ¿Considera que en los últimos años ha cambiado la forma en que se habla o se ve la salud mental en el distrito?
- ¿Cree que el centro ha tenido algo que ver en ese cambio? ¿Podría explicar de qué manera cree que se relaciona el centro comunitario en ese cambio?
- ¿Antes de acudir al centro, qué pensaba usted (o su entorno) sobre la salud mental, y qué percepción tiene ahora?

Con respecto a la **participación en actividades de fortalecimiento comunitario:**

- ¿Ha participado usted o alguien que conoce en actividades comunitarias organizadas por el centro, como talleres, ferias o campañas? Cuente su experiencia.
- ¿Cuál es su percepción de dichas actividades comunitarias?
- ¿Considera que esas actividades organizadas por el centro fortalecen la unión y participación en su comunidad? ¿Por qué sí o por qué no?

Notas para la entrevistadora:

- Permitir que el entrevistado se exprese con libertad.
- Pedir ejemplos o experiencias concretas siempre que sea posible.
- Si surge un tema emergente relevante, puedes explorarlo aunque no esté en la guía.
- Registrar respuestas completas y grabar con consentimiento.